

통합 6년제 학생맞춤형 교육과정 개발·운영

1차년도 성과 정리본 · 2025-2026

공통 핵심역량 위에 진로트랙, 몰입형 경험(EP), 종단적 진로코칭을 연결한 6년 나선형 교육과정 모델을 개발했습니다.

홈페이지에 공개된 주요 결과와 세부 성과를 모은 자료입니다. 원본 보고서와 구분됩니다.

핵심 성과

38개교 · 적용 계획 도출

6개 · 특성화 트랙

4개 안 · 교육과정 편성 모델

- 교육목표→도달역량→역량별 교육과정→편성→실행의 5단계 공동 개발 절차를 정립했습니다.
- 4대 교육목표와 5대 도달역량을 도출하고, 의사과학자·지역사회의료·미래의료 및 디지털헬스·의료경영 및 정책·국제보건 및 글로벌헬스·교수요원 양성의 6개 트랙을 구성했습니다.
- EP 9주, 18주, 18주+7주, 28주+7주 등 대학 여건에 맞는 네 가지 편성안을 마련했습니다.
- STEPS 진로코칭을 자기진단-구조화-목표설계-실행-성찰의 다섯 단계로 표준화했습니다.
- 가이드북과 리플렛을 제작·배포하고 38개교 적용 계획 도출을 지원했습니다. 이는 계획상 32개교 목표를 초과한 실적이며, 38개교의 실제 운영 완료를 의미하지 않습니다.
- 워크숍 5회, 세미나 3회, 연구회의 6회, 실무진 회의 25회를 운영하고 38개 대학의 사례를 정리했습니다.

주요 산출물

- 학생맞춤형 교육과정 개발·운영 가이드북

- STEPS 진로코칭 리플렛
- 표준 서식 9종
- 편성안 1~4안 및 38개교 적용 계획

세부 성과 목차

01 · 사업 개요

02 · 추진 경과

03 · 추진 결과

04 · 주요 성과 및 산출물

01 사업 개요

1. 사업명

통합 6년제 학생맞춤형 교육과정 개발·운영 (의과대학 교육혁신 지원사업 세부 추진과제)

2. 추진 배경 및 필요성

(학제 개편) 교육부 「고등교육법 시행령」 개정으로 기존 예과 2년·본과 4년(2+4년제) 체제가 통합 6년제로 전환 가능해짐에 따라, 의과대학이 6년 범위에서 유연하게 교육과정을 편성·운영할 수 있는 제도적 기반이 마련됨. 그동안 예·본과 교육과정 간 연계 미흡, 본과 4년 교육과정의 과밀 문제가 지속적으로 지적되어 왔으며, 학제 전환기(2024~2025학년도 학생 동시 재학 등)에 따른 교육인원 증가로 개별 대학의 교육 부담이 가중되고 있음

(미래역량 요구) 급변하는 의료 환경과 기술 발전에 따라 창의성, 비판적 사고력, 협업 역량 등 미래지향적 역량의 중요성이 커지고 있으며, 이에 부합하는 교육과정 혁신이 요구됨

(필수·공공의료) 지역사회 기반 필수의료의 중요성과 관련 의학교육의 필요성이 높아지고 있으나, 현행 교육과정에는 지역보건, 노인의학, 공공의료 등 필수의료 관련 교육 기회가 부족함

(학생 맞춤형 교육) 의과대학 평가인증에서 학생 선택권 확대와 다양한 의료인문학 교육을 장려하고 있으며, 학생 개개인의 자기이해·진로탐색·진로결정을 체계적으로 지원하는 학생 중심 교육과정으로의 전환이 필요함

3. 추진 목적

각 대학의 특성과 교육 여건, 학생 개인의 진로 목표·관심 분야·역량 수준을 반영한 다양한 진로트랙 기반의 6년 나선형(Spiral) 교육과정을 설계하고, 트랙별 교육과정과 실제 임상실습, 학생 평가 및 교수 체계까지 통합적으로 설계함

학생의 자기이해·진로탐색·진로결정을 지원하는 학생맞춤형 교육과정 운영 모델과 진로코칭(Career Path Coaching) 프로그램을 개발하여 전국 의과대학에 확산함

4. 추진 내용

(학생맞춤형 교육과정 및 진로코칭 프로그램 계획 도출) 6년 전(全) 과정을 다양한 진로 트랙(의사과학자 양성, 지역사회의료, 미래의료·디지털헬스, 국제보건·글로벌헬스, 의료정책·경영, 의학교육자 양성 등)과 Enrichment Period(EP), 지원체계와 연계한 나선형 교육과정 설계 및 32개교 계획 도출

(학생 평가 체계 구축) 개발된 트랙별 교육과정을 교육 현장과 연계하고, 학생 이력 및 성취도 기반 평가 체계 구축을 위한 학생 평가 매뉴얼 개발
(교수개발 프로그램 운영) 교육과정 운영에 필요한 다양한 교수법 연수 및 임상실습 담당교수 대상 학생 평가역량 강화 연수 운영

5. 추진 방법 및 체계

한국의과대학·의학전문대학원협회(KAMC)가 사업을 총괄 운영하고, KAMC 내 의대교육지원센터를 중심으로 KAMC 전문위원 및 의과대학 연구위원으로 구성된 전담 TF를 구성·운영함

TF는 교육과정 개발 5단계 프로세스(교육 목표 → 도달 역량 → 역량별 교육과정 → 교육과정 편성 → 실행 방안)에 따라 워크숍 방식의 공동 개발 회의를 순차적으로 진행하고, 그 결과를 종합하여 표준 운영 모델과 대학별 적용(안)을 도출함

6. 설계의 이론적·정책적 기반과 국제 사례

가. 통합 6년제의 본질과 Core plus 교육과정

통합 6년제 전환의 법적 근거는 2024년 2월 「고등교육법 시행령」 개정으로 마련되었으며, 이는 1924년 예과 제도 도입 이후 약 100년 만의 학제 근본 개편이다. 고령화·만성질환 증가, AI·디지털 확산, 지역 간 의료격차, 다직종 협력 확산 등 의료환경의 변화는 임상적 판단력·협업 능력·시스템 이해·사회적 책무성을 갖춘 새로운 의사상을 요구하며, 성과바탕(OBE)·역량바탕(CBME) 의학교육과 나선형 교육과정으로의 패러다임 전환을 촉진하고 있다.

연구팀은 통합 6년제를 단순한 "학제 통합"이 아니라 "역량 발달 과정의 통합"으로 정의하였다. 즉, 입학부터 졸업까지 학생의 성장·전문직 정체성·진로탐색·임상 역량 발달을 하나의 교육과정 지도로 연결하는 종단적 교육과정이며, 1-2학년(발견: 기초·탐색·자기이해·조기임상노출·Track 소개) → 3-4학년(수행: Track 선택·EP 프로젝트 수행) → 5-6학년(재해석·통합: 임상실습에서 EP 산출물 재해석·졸업 전 전문성 개발 계획)의 구조를 갖는다. 기존 2+4 구조에서는 예과-본과 분절로 자기이해·진로탐색·성찰의 여백이 부족하였고, 맞춤형 교육이 선택과목의 양적 확대에 머물러 산출물이 단절되는 한계가 있었다. 통합 6년제의 정당성은 "6년이 기 때문에 가능하다"가 아니라 "6년을 하나의 설계 단위로 사용할 때 맞춤형 성장이 실제로 작동한다"는 데 있다.

이러한 관점에서 본 과제는 「Core plus 교육과정」을 설계 철학으로 채택하였다. Core plus 교육과정은 기존의 중핵교육과정(core curriculum) 개념을 바탕으로 필수적이고 공통적으로 중요한 학습 내용을 중심(core)으로 하되, 변화하는 의료 환경과 미래 사회의 요구에 대응하여 기존 내용을 재구성(reconstruction)하고 현재와 미래의 상황에 맞는 혁신적 요소(innovation)를 설계·운영하는 교육과정으로 정의된다. 즉 "Core로 기본을, Plus로 대학 특성을 구현한다"는 원칙 아래, 공통 핵심역량 위에 학생맞춤형 교육과정·지역사회기반 교육과정·디지털 전환 교육과정·의사과학자 양성 교육과정·IPE·공유대학 등 대학별 특성화 요소를 더하는 구조이다.

나. 통합 6년제 맞춤형 교육과정의 필수 구성요소 8가지

연구팀은 "선택할 자유"가 아닌 "구조화된 자율성(structured autonomy)"을 실행하기 위한 8개의 필수 구성요소를 다음과 같이 정리하였다. 공통 핵심역량 위에 Track·EP·STEPS 코칭·e-Portfolio·성과 기반 평가를 정렬(align)함으로써 학생의 선택을 검증 가능한 교육성과와 전문성 개발로 전환하는 것이 통합 6년제의 본질이다.

#	필수 요소	최소 설계 기준	교육적 기능
①	공통 핵심교육(Common Core)	졸업성과 기반 필수 교육	Track 선택과 무관하게 모든 학생이 달성해야 할 역량(기초·임상·윤리·전문직업성) 보장
②	Track 특성화 종단 경로	기존 선택과목을 6개 Track 심화 경로로 재구조화	산발적 선택 → 진로심화 경로로 전환(의사과학자·지역사회의료·디지털헬스·국제보건·의료정책·의학교육자)
③	Enrichment Period I	4학년 전후 9-28주 몰입형 실제 경험	선택 → 계획 → 실행 → 중간점검 → 산출 → 성찰의 핵심 장치; 연구/지역/글로벌/정책/디지털/교육 프로젝트
④	5학년 임상 연계(Clinical Integration)	임상실습 중 Track 관심을 실제 환자·팀·기관 맥락에서 재검토	프로젝트와 임상역량의 분리 방지; WBA·임상지도교수 피드백·Track 지도교수 면담
⑤	EP II / 졸업 캡스톤	6학년 또는 졸업 전 4-7주 전환 프로그램	전공 선택·졸업 후 전문성 개발 계획 정리; 졸업 포트폴리오·3년 CPD 계획
⑥	STEPS 종단 코칭	입학-졸업 종단 코칭(Screening→Thinking→Expressing→Performing→Strengthening)	선택의 질 제고와 중도 이탈·형식화 방지; 학생·교수·학교 3주체 역할 분담
⑦	e-Portfolio(Evidence Base)	계획서·활동기록·피드백·산출물·성찰 누적(LMS 연동)	성과 기반 평가와 진로상담의 근거; programmatic assessment 실행 도구

<표 1> 통합 6년제 맞춤형 교육과정의 필수 구성요소 8가지

다. 해외 의과대학 6년제 벤치마킹

해외 6개 의과대학의 통합 6년제 운영 사례를 검토한 결과, 공통 원리는 학제의 길이가 아니라 "의학교육의 핵심 역량을 훼손하지 않으면서 학생 선택과 심화 경험을 공식 교육과정으로 편입하는 것", 즉 교육과정 내 선택·탐색·연구·임상연계의 제도화에 있었다. 이는 한국형 통합 6년제에서 EP를 필수 학점화하고, 선택과목을 Track으로 구조화하며, 심화 Track을 임상 접착과 단절시키지 않아야 한다는 설계 원칙으로 반영되었다.

대학·제도	핵심 특징	한국형 통합 6년제 시사점
HKU MBBS(홍콩대)	3학년 필수 Enrichment Year: Research·서비스/인도주의·intercalation/교 환·자기주도 experiential learning	EP I 을 필수 학점화하되 지도·재정·정보 지원 포함
CUHK Medicine(홍콩중문대)	학생이 하나 이상의 self-initiated intercalated year를 선택할 수 있는 유연 성	모든 학생 필수 EP + 우수·준비된 학생 대상 Extended EP 구분
UCL Medicine(런던)	6년 과정에 integrated BSc 포함, 임상·전문직 실천 모듈 중단 운영, SSC(Student Selected Component)를 핵심 선택요소로 운영	선택과목을 Track화하고 공통역량 달성과 개별 관심 심화 병행
Cambridge Medicine	3학년 Part II에서 폭넓은 전문 분야 탐구·BA 취득, 환자 접착 지속	심화연구·인문사회·정책·교육 Track을 임상 접착과 단절시키 지 않음
Edinburgh MBChB	6년 과정에 3학년 연구 기반 학습 포함, 임상훈련을 전 과정에 배치	의사과학자 Track과 연구 기반 EP의 제도적 필요성
Imperial Medicine(런던)	기술 변화와 미래 의료·초기 임상기술·환자경험·연구기술 적용을 통합	미래의료·디지털헬스 Track을 선택과목이 아닌 핵심 특성화 경로로 설계

<표 2> 해외 의과대학 6년제 벤치마킹 결과

아울러 intercalated degree 관련 연구(Cleland 등, 2009; Al-Busaidi 등, 2025)는 1년의 연구·심화 과정 이수자가 이후 시험 성과, 졸업 후 논문 출판, 상위 학위 취득 가능성에서 유의한 이점을 보인다고 보고하고 있어, 모든 학생에게 강제하지 않더라도 연구·심화·프로젝트 경험이 학습전략·학문 정체성·장기 진로에 의미 있는 영향을 미침을 시사한다.

라. 교육학 이론 기반

통합 6년제 학생맞춤형 교육과정 설계는 다음의 9가지 교육학 이론에 근거하며, 각 이론은 교육과정 구조·평가·교수 역할·행정 지원으로 구체화되었다.

이론	핵심 내용	본 교육과정에서의 적용
통합·나선형 교육과정	기초과학·임상의학·전문직업성·사회과학을 전 학년 통합·나선형으로 설계	전 학년 통합 블록, 임상교육 강화, 고학년 기초의학 재방문
SPICES 모델(Harden)	Student-centred·Problem-based·Integrated·Community-based·Elective·Systematic	"학생 선택"만이 아니라 공통핵심·지역기반·체계 운영을 함께 설계
역량기반 의학교육(CBME/OBE)	졸업성과와 관찰 가능한 역량 중심으로 교육과정과 평가를 역설계	Track은 공통성과를 대체하지 않고 그 위에 학생별 심화성과 추가
자기주도학습(SDL)·성인학습	학습 필요 진단 → 자원 선택 → 실행 → 평가를 학생이 수행	EP 계획서·중간보고·최종 성찰·후속 학습계획 필수화
자기결정성이론(SDT)	자율성·유능감·관계성 충족 시 학습 동기와 웰빙 강화	무제한 자유가 아닌 지도교수·동료·기관과 연결된 구조화된 선택권
경험학습·성찰실천(Kolb)	구체적 경험 → 성찰 → 개념화 → 재실행의 순환으로 전문성 형성	4·5학년 실제 프로젝트·임상실습 + 사전·중간·사후 성찰 결합
상황학습·실천공동체(CoP)	학습은 실제 현장과 전문직 공동체 참여 속에서 일어남	연구실·보건소·병원·NGO·정책기관·교육센터 Track 멘토링
구성적 정렬(Biggs)	목표·교수학습활동·평가의 일치	Track 목표 ↔ EP 산출물 ↔ 루브릭 ↔ 포트폴리오 ↔ 졸업성과 일치
Kern의 6단계 교육과정 개발	문제 확인 → 요구분석 → 목표 → 교육전략 → 실행 → 평가·환류	대학·학생·지역사회 요구조사 후 Track·EP 규모를 단계적으로 확장

<표 3> 통합 6년제 설계의 교육학 이론 기반과 적용

02 추진 경과

1. 교육과정 개발 5단계 프로세스 정립

연구팀은 학생맞춤형 교육과정 개발과 진로코칭 적용을 위한 표준 개발 절차로서 다음의 「교육과정 개발 5단계 프로세스」를 정립하고, 각 단계별로 KAMC 워크숍을 진행하여 공동 개발 결과를 도출하였다.

단계	구분	내용
1	교육 목표	조직의 비전과 미션을 기반으로 교육을 통해 달성하고자 하는 명확한 목표를 설정한다. 단기·중기·장기적 관점에서의 목표를 구분하여 정의한다.
2	도달 역량	교육을 통해 습득해야 할 핵심 역량과 기술을 정의한다. 요구되는 역량을 세분화하여 역량 프레임워크를 구축한다.
3	역량별 교육과정	정의된 역량을 개발하기 위한 구체적인 교육과정을 설계한다. 각 역량별로 필요한 교육 내용, 교수법, 학습 방법을 결정하고 체계화한다.
4	교육과정 편성	공식 교육과정(강의, 워크숍, 세미나)과 비공식 교육과정(멘토링, 코칭, 현장 실습 등)을 체계적으로 편성한다. 교육 대상, 시기, 기간, 방법을 구체화한다.

2. 워크숍·세미나 추진 일정 및 운영 실적

연구팀은 2025년 7월부터 2026년 5월까지 총 워크숍 5회, 세미나 3회, 연구회의 6회, 실무진 회의 25회를 운영하였다. 각 워크숍·세미나 사이에는 실무진 회의를 통해 결과를 정리하고 다음 단계를 준비하는 방식으로 순차 진행하였으며, 세부 일정과 주요 내용은 다음과 같다.

구분	일자	주요 내용
1차 워크숍	2025.07.30	사업 필요성·범위·추진 방법 공유, 국내외 EP·진로설계 사례 검토
2차 워크숍	2025.09.04	개념·교육목표·도달역량 도출, 부산·충남·서울의대 사례 공유
3차 워크숍	2025.10.17	EP 주제/기간/운영 원칙 합의, 나선형 연계, 코칭·지도 구조 설계
4차 워크숍	2025.12.16	대학 유형별 EP 설계안, 전국 설문 기반 쟁점 도출
제1회 세미나	2026.02.06	의대 교육혁신사업 진행 과정 공유, 6년제 졸업성과 개정
5차 워크숍	2026.03.04	6개 트랙, EP 포함 편성(안), STEPS 코칭 전략, 실행 인프라
제2회 세미나	2026.03.30	지역의료 교육 대학별 사례 포함, 성과 공유
제3회 세미나	2026.05.15	1차년도 종합 성과 공유 및 향후 계획 수립

<표 A> 워크숍·세미나 추진 일정(2025.7~2026.5, 전체 완료)

[그림 A] 학생 맞춤형 교육과정 개발 추진 일정(워크숍 5회·세미나 3회, 실무진 회의 연계)

전체 추진 과정은 ① 문제 인식(과제 착수, 필요성 분석) → ② 사례 검토(국내외 EP·진로설계 선진사례 분석) → ③ 개념 도출(교육목표·도달역량, EP 운영 원칙) → ④ 모델 구체화(6개 Track·EP, STEPS 코칭) → ⑤ 적용 확산(38개교 적용, 가이드북 배포)의 5단계 플로우로 진행되었다.

[그림 B] 현재까지 경과: 운영 현황(워크숍 5회, 연구회의 6회, 실무진 회의 25회), 주요 성과(38개교 적용 계획 도출 지원, 6개 특성화 Track), 단계별 진행 플로우

3. KAMC 워크숍 운영

연구팀은 「학생맞춤형 교육과정 개발과 진로코칭 적용」을 주제로 KAMC 워크숍을 수 차례에 걸쳐 운영하였다. 워크숍에서는 참여 위원들이 명목집단기법(스티커 투표) 기반의 아이디어 도출·수렴 활동을 통해 교육 목표와 도달 역량의 우선순위를 결정하였으며, 역량별 교육과정 설계 워크시트를 활용하여 트랙별 교과목(안)을 공동 작성하였다.

03 추진 결과

1. 교육 목표 도출

가. 워크숍 기반 교육목표 후보 도출 및 우선순위 결정

워크숍 참여 위원들이 통합 6년제 학생맞춤형 교육과정(Enrichment Period 포함)이 지향해야 할 교육목표 후보를 자유롭게 제안한 후, 유사 항목 군집화와 스티커 투표를 통해 우선순위를 결정하였다. 총 27개 항목이 제안되었으며, 상위 득표 결과는 다음과 같다.

구분	교육목표	득표수
1	자기주도 / 자기주도성(학습자 주도적 진로설계, 학습참여, 성취) / 자기주도형 인재 양성 / 자기선택	7
2	전인성(전문성+인성+윤리) / 의학전문가로서의 전문성 / 전문성 함양	5
3	자아실현 / 학생의 자아(기) 실현 지원 / 자아실현 촉진	4
4	융합성(기초·임상·인문사회 융합 강화, IPE 강화, 이론-실습 연계 강화 등)	2
5	학생 성장 / 자기계발+자기개발	2
6	자기이해 / 자기이해 역량	2
7	우수한 학습역량	2
8	다양한 경험과 기회 제공	2
9	교육과정의 '공통성' 그리고 '다양성'	2
10	학습선호·역량발달수준 고려 / 개별화(학생의 필요·요구 반영, 발달 단계별 맞춤형 교육과정)	1
11	진로탐색 · 측은지심 · 자기주도 생활력 · 현실적 상상 역량	각 1
-	(기타) 교육과정의 유연성 보장, 연속성(6년 학부과정의 유기적 연결·나선형 교육과정), 지역책임성, 혁신성(디지털·AI 기반 교육 혁신), 타인(타분야) 이해, 책임감, 풍부한 교양, 회복탄력성, 스토리텔링·스토리라이팅 역량, 직업 탐색 역량, 사회기여 유도 등	-

<표 4> 교육목표 우선순위 도출 결과(스티커 투표)

나. 교육목표 체계(VISION-목적-목표) 확정

도출된 우선순위(자기주도성, 전인성, 자아실현, 자기이해 등)를 종합하여 다음과 같이 학생맞춤형 교육과정의 VISION, 목적, 목표를 확정하였다.

VISION	자기 이해를 기반으로 다양한 전문 분야를 탐색하고 주도적으로 성장하도록 지원하여, 전문성과 인성을 조화롭게 갖춘 의료 리더를 양성한다.
목적	학습자가 자신의 흥미와 역량을 깊이 이해하고, 주도적으로 학습과 진로를 설계하며, 전문성과 인성을 조화롭게 발전시킬 수 있는 개인 맞춤형 교육 환경을 구축한다.
목표	1. 자기 이해 기반의 진로 설계 2. 자기주도적 학습과 성찰을 통한 성장 3. 고등사고능력과 통찰을 통한 문제해결력 강화 4. 다양한 경험과 탐색을 통한 전인적 전문성 함양

<표 5> 학생맞춤형 교육과정 교육목표 체계

2. 도달 역량 도출

가. 워크숍 기반 도달역량 후보 도출 및 우선순위 결정

교육목표와 동일한 절차로 도달역량 후보 총 32개 항목을 도출하고 스티커 투표로 우선순위를 결정하였다. 상위 득표 결과는 다음과 같다.

구분	도달 역량	득표수
1	커리어 디자인(Career Design) 역량 / 진로 설계 역량	5
2	자기주도학습 역량	4
3	자아성찰 역량	4
4	자기이해 역량	4
5	자기주도적으로 학습이나 성찰을 수행할 수 있다	3
6	진로 탐색 및 선택	3
7	평생학습 역량	3
8	공감 역량	2
9	목표 실현 역량 · 글로벌 및 디지털 역량(융합적 사고·연구 역량) · 비판적·창의적 사고 · 의사소통 역량 등	각 1
-	(기타) 문제해결 역량, 사회인지·변화인지 역량, 윤리 및 전문직업성 역량, 기초·임상·인문사회 연계 역량, 지역사회 책무성 역량, 환자중심진료 역량, 융합적 사고, 자기조절 역량, 지식습득과 해석(AI 이용), 전문가 간 협업 역량, 정보탐색 역량, 선택 및 결정 역량 등	-

<표 6> 도달역량 우선순위 도출 결과(스티커 투표)

나. 교육목적-교육목표-도달역량 체계 확정

우선순위 결과를 종합하여 5대 도달역량을 다음과 같이 확정하였다: ① 자기이해 및 성찰 역량, ② 자기주도적 학습 및 탐색 역량, ③ 비판적·융합적 사고 역량, ④ 소통 및 협업 역량, ⑤ 진로·경력 설계 역량(커리어디자인 역량). 교육목적-교육목표-도달역량의 전체 연계 체계는 [그림 5]와 같다.

3. 역량별 교육과정 설계

확정된 도달역량을 개발하기 위한 역량별 교육과정을 워크숍 워크시트(교육과정 목표-도달 역량-교과목명-주요 학습내용-교과목별 학습목표-교수학습 방법-학생평가 방법)를 활용하여 조별로 설계하였으며, 그 결과를 정리하여 대표적으로 「의학연구·탐구 기반 교육과정(Research & Inquiry Track)」과 「진로·경력설계 기반 교육과정(Career Design & Development Track)」의 2개 교육과정(안)을 도출하였다.

가. 의학연구·탐구 기반 교육과정 (Research & Inquiry Track)

교육과정 목표: 의학연구 및 탐구 기반 사고를 함양하여 임상과 기초 연구를 통합적으로 수행할 수 있는 연구자적 역량을 기른다.

교과목명	주요 학습내용	교과목별 학습목표	교수학습 방법	학생평가 방법
의학연구 입문 (4주)	연구 주제 선정 및 가설 수립 / 실험·임상 연구 설계 실습	연구 질문과 가설을 설정할 수 있다. 기초 또는 임상연구 설계를 수행할 수 있다.	TBL, Flipped Learning	보고서 제출, 참여도
의학연구 심화 (4주)	선행 의학연구 설계 수정 및 시행 / IRB 서류 작성 및 DRD(Data-Research-Design)	IRB 문서를 작성할 수 있다. 실제 데이터 기반 연구 설계를 적용할 수 있다.	강의+실습+연구실 기반 피드백	연구계획서 평가, 발표
병원 현장 경험 탐색 (2주)	한 학생당 지정 병원의 현장 탐방 / 의료직 종 간 협업 및 환자 흐름 이해	의료현장에서 다학제 협력과정을 이해한다. 병동의 흐름과 의료 시스템을 설명할 수 있다.	현장실습, 관찰, Q&A	현장보고서, 지도교수 피드백
보건의료정책 및 문제해결 탐구	보건정책 개선 과제 도출 / 실제 의료현장의 문제 Q&A 분석 및 정책 제안	보건의료 문제를 분석하고 해결안을 제시할 수 있다. 정책 제안서를 작성할 수 있다.	토의, 프로젝트 기반 학습	정책 제안서, 토론 참여도
의학연구 세미나	연구 결과 발표 및 피드백 / 논문 구조, 학술적 글쓰기, 통계 활용	학술 발표 및 논문 초안을 작성할 수 있다.	세미나, 발표, 피드백	발표 평가, 동료평가
국제보건선교 (4주)	해외 보건 의료 경험 / 국제보건 의료체계 탐색	다양한 국가의 보건의료체계를 비교·분석할 수 있다.	현장조사, 사례학습, 그룹활동	참여도, 보고서, 프레젠테이션

<표 7> 의학연구·탐구 기반 교육과정(안)

※ 연계 도달역량: 자기이해 및 성찰 역량, 자기주도적 학습 및 탐색 역량, 비판적·융합적 사고 역량, 소통 및 협업 역량, 진로·경력 설계 역량(연구/학술 진로 포함)

나. 진로·경력설계 기반 교육과정 (Career Design & Development Track)

교육과정 목표: 의학전문 직업인으로서 자기이해를 기반으로 진로를 탐색하고, 개인의 강점과 가치에 맞는 경력(Career Path)을 설계·실행할 수 있는 역량을 기른다.

교과목명	주요 학습내용	교과목별 학습목표	교수학습 방법	학생평가 방법
Career Design	자아탐색, 가치관 분석, 직업세계 이해 / 진로로드맵(Planning) 수립	자기이해를 기반으로 진로방향을 설정할 수 있다. 진로로드맵을 작성할 수 있다.	강의, 토의, 진로워크숍	진로로드맵 제출, 참여도
지역사회와 의료	지역사회 의료문제 이해 / 공공보건 및 의료불균형 탐색	지역사회 보건의료의 구조와 문제를 설명할 수 있다. 지역의료 진출 가능성을 탐색한다.	사례분석, 발표, 현장연계	발표, 보고서
Career Crafting	자신의 직무·미래를 스스로 설계하는 과정 / 변화하는 직업세계에 대한 적응전략	자신의 직무경로를 설계할 수 있다. 변화하는 의료환경에 진로대응 전략을 수립할 수 있다.	프로젝트 기반 학습(PBL), 피드백, 포트폴리오	포트폴리오 평가, 피드백 반영 점수
진로개발과 전공선택 (2학년)	전공 정보 탐색 / SWOT 분석, 멘토 상담	자신에게 적합한 전공을 근거 기반으로 선택할 수 있다.	멘토링, SWOT 워크숍	결과보고서, 멘토 피드백
임상의학 진로체험 (5-6학년)	임상실습 중 실제 진로 경험 / 전공의·전문의 인터뷰	임상 진로의 실제 흐름을 이해하고 설명할 수 있다.	현장실습, 인터뷰, 발표	임상 경험 리포트
진로세미나 & 포트폴리오	진로계획 발표 및 피드백 / 나의 Career Path 공유	자신의 진로를 발표하고 타인의 피드백을 반영할 수 있다.	세미나, 토론, 피어리뷰	발표 평가, 포트폴리오 완성도
국제보건·글로벌 진로 (선택)	WHO, NGO, 국제보건의료체계 탐구 / 해외 의료진로 옵션 이해	글로벌 헬스 분야의 진로경로를 설명할 수 있다.	사례학습, 국제자료 분석	보고서, 발표

<표 8> 진로·경력설계 기반 교육과정(안)

※ 연계 도달역량: 자기이해 및 성찰 역량, 자기주도적 진로탐색 역량, 비판적·문제해결 사고 역량, 소통 및 협업 역량, 진로 및 경력설계(커리어디자인) 역량

4. 교육과정 편성: Enrichment Period(EP) 설계

교육과정 편성 단계에서는 ① Enrichment Period 주제(트랙) 설정, ② EP 기간 및 운영방법, ③ 나선형(Spiral) 교육과정 구조 설계, ④ EP 코칭 전략 설계의 네 가지 세부 과제를 순차적으로 수행하였다.

가. Enrichment Period 주제(트랙) 설정

워크숍 토의를 통해 학생 진로 유형과 국가·사회적 의료 수요를 반영한 6개 EP 트랙을 설정하고, 트랙별 교육목표와 주요 활동/프로그램 내용을 다음과 같이 구체화하였다.

트랙명	교육목표	주요 활동/프로그램 내용
1. 의사와학자 트랙 (Physician-Scientist Track)	기초의학-임상의학-연구를 연결하는 연구역량과 학문적 호기심을 기른다.	기초/임상의학 연구실 배정 및 멘토링, 실험 디자인·IRB 작성 실습, 논문 리딩 & Journal Club 참여, '의사와학자 선배 특강 및 커리어 Q&A'
2. 지역사회 의료 트랙 (Community Medicine Track)	지역사회 건강문제를 이해하고 공공의료 실천 역량을 기른다.	보건소·공공병원·군의원 등 현장 실습, 지역사회 주민 건강조사 & 사례 분석, 보건의료 취약지 탐방, '공중보건의·보건소장 초청 강연'
3. 미래의료 & 디지털 헬스 트랙 (AI-Digital Health Track)	인공지능, 데이터, 디지털 기술을 의료에 적용하는 역량을 기른다.	의료 AI 원리·데이터 분석 실습(Python, R 가능), 웨어러블·의료 메타버스·원격 의료 서비스 체험, 디지털 헬스 스타트업 방문, 의료 AI 윤리·법적 쟁점 토론
5. 국제보건 및 글로벌 헬스 트랙 (Global Health Track)	저개발국·국제기구의 보건체계와 글로벌 헬스 이슈를 이해한다.	WHO·UNICEF·KOICA·MSF 활동 사례 학습, 해외 보건의료 모델(영국 NHS, 미국 등) 비교, 국제보건 실습 혹은 온라인 필드워크(예: Global Health 국제 MOOC 과정), '의대생 해외의료봉사 vs 지속가능성' 토론
6. 교수요원 양성 트랙 (Medical Educator Track)	미래 의학교육 전문가(교수, 교육자)로서의 역량을 기른다.	TBL·PBL·Flipped Classroom 설계 실습, 임상수업 OSCE 지도법·피드백 기술 훈련, 교육학·교육과정 설계·평가론 학습, '의대 교수 되기' 특강 + 모의 강의 (Micro-teaching)

<표 9> Enrichment Period 6개 트랙 구성(안)

나. EP 기간·운영방법 및 나선형(Spiral) 교육과정 구조 설계

6년 전 과정에 걸쳐 트랙 소개(Pillar) → 트랙 탐색 → 트랙 심화로 이어지는 나선형 구조를 설계하였다. 1안은 1학년 초 EP 오리엔테이션과 학기 말 Pillar 주제 운영, 2학년 전 Pillar 순환, 3학년 Pillar 세미나, 4학년 2학기 및 6학년 상반기 EP 집중 운영을 골자로 하며, 2안은 2-4학년 학기 말 Pillar 기간 운영과 4학년 2학기 탐색형 EP(2개 트랙), 6학년 상반기 심화형 EP(1개 트랙) 집중 배치를 골자로 한다. 두 안 모두 방학과 정규학기 사이 전환 구간을 활용하여 정규 교육과정 부담을 최소화하도록 설계하였다. 워크숍 단계에서 도출된 이 두 가지 설계안은 이후 가이드북 및 편성표 종합 보고서 작업을 거쳐, Track 수(2개 → 4개)와 EP 기간(9주 → 18주 → 18주+7주 → 28주+7주)을 축으로 하는 교육과정 편성(안) 1안~4안으로 정교화·확정되었다(IV.6.가·나 참조).

다. EP 코칭 전략 설계

EP 운영의 실효성을 확보하기 위하여 학생 개인별 진로코칭을 결합한 「Career Path Coaching 전략」을 별도 과제로 설계하였다. 코칭 전략은 자기이해(심리검사, MMPI 등) 기반 진로 멘토링, 면담조 상담, 포트폴리오 기반 성찰-피드백 순환 구조를 포함하며, 트랙 선택 이전 단계부터 졸업 후 진로 확정까지 연속적으로 학생을 지원하도록 구성하였다.

5. 대학 적용 사례: P대학 통합 6년제 교육과정 전면 개편

개발된 학생맞춤형 교육과정 운영 모델의 현장 적용 가능성을 검증하기 위하여, 통합 6년제 트랙형 교육과정을 선도적으로 개편한 P대학 사례를 분석·공유하였다.

가. 개편 배경

교육부 「고등교육법 시행령」 개정안 입법예고로 2+4년제 의과대학 학부 교육과정의 통합 6년제 전환이 가능해짐. 예·본과 교육과정 간 연계 미흡, 본과 4년 교육과정 과밀 문제를 해소하고 6년 범위에서 유연한 교육과정 운영 가능

(학생 교육 선택권 확대) 의과대학 평가인증의 선택권 확대 권고에 따라 1·2학년 전공선택 교과목, 자기계발 교육과정, 4학년 전공선택실습을 운영 중이며, 통합 6년제에 펜토미노 교육과정을 도입하여 학생 개별 중심 교육과정 실천 기대

(인문학 교육 강화) 예비의사의 인문학적 소양, 의사소통·전문직업성 역량 제고를 위해 모든 학생 대상 인문학 기본 교육과 관심 학생 대상 심화 교육 제공

(필수의료·공공의료 진로 교육 확대) 필수의료·공공의료 인력 부족 문제에 대응하여 학부 교육에서부터 필수 임상과와 공공의료 경험 확대, 본과 3·4학년 선택실습과정에 필수·공공의료 인력 양성 트랙 적용

(의사과학자 등 심화 트랙) 의학전문대학원 학제에서의 의사과학자 양성 경험을 바탕으로 연구 역량을 높일 수 있는 트랙 개발

나. 연구 추진 절차 및 방법

P대학은 교육부학장을 연구책임자로 하고 연구부학장, 교육과정위원장, 의학과장, 의학교육학교실 교수진이 공동연구자로 참여하는 연구책임팀을 구성하였으며, 19개 과목 이상의 교과목 개발(트랙별 코디네이터 교수 지정)과 24명 이상의 외부 전문가 자문위원회를 운영하였다. 연구는 2023년 12월부터 2024년 12월까지 환경 분석(Analysis) → 수요 조사(Needs Assessment) → 설계(Design) → 교육과정 구성(Development)의 절차로 진행되었다.

단계	주요 내용
환경 분석 (Analysis)	국내외 기본의학교육 과정 분석, 통합 6년제 모델 조사, 타 의과대학 교육과정 분석, 관련 문헌 및 연구 검토
수요 조사 (Needs Assessment)	트랙별 전문가 자문, 학생 FGI 2회 실시, 교수 및 학생 대상 설문조사, 자문위원회 피드백
설계 (Design)	모듈 및 트랙 설계, 펜토미노 교육과정 로드맵, 학년별 교육과정 구조화, 수업 및 평가방식 설계
교육과정 구성 (Development)	교육과정안 도출, 트랙별 과목 선정, 세부 교육내용 개발, 시행계획 및 피드백 구조화

<표 10> P대학 교육과정 개편 연구 추진 절차(2023.12-2024.12)

다. 교수·학생 설문조사 결과

(교수, 70명 참여) 87.1%가 통합 6년제 교육과정 개편에 찬성. 찬성 이유는 ① 예과-본과 연속성 강화 및 교육과정 통합, ② 학생 소속감 증대·교육 효율성 향상, ③ 교육과정 편성 유연성 확대 순. 우려 사항은 ① 다른 학문과의 교류 기회 축소, ② 기초과학 교육 감소 가능성, ③ 교육시설 및 교수 부담 증가 순

(학생, 360명 참여) 57.3%가 통합 6년제 교육과정 개편에 찬성. 찬성 이유는 ① 예과-본과 연속성 강화 및 효율적 교육과정, ② 방학 연장을 통한 스트레스 완화 기대 순

라. 트랙별 교육과정 개요(안)

P대학의 통합 6년제 트랙형 교육과정 편성(안)은 다음과 같다. Phase 1-2(1-2학년)에서 맞춤형 진로탐색(Pillar 1-2), Phase 2-3(3-4학년)에서 맞춤형 트랙(Pillar 3-5)을 배치하고, 4학년 2학기에 맞춤형 트랙 집중 학기(Enrichment Period)를 운영한다. 5-6학년 임상실습에서는 1·2차 의료기관 파견과 보건소·복지관·공공의료 기관 파견을 포함한 지역사회기반 실습을 편성하였다. 트랙은 필수의료, 지역사회의료, 글로벌리더, 의사과학자, 자율융합전공의 5개로 운영한다.

트랙	주요 교과목 및 수업방법
의사과학자 트랙	분자세포의학연구, 효능평가연구, 의학연구역사, 실험실순환, 의학심화연구 I~IV 등 / 공대 협동과목, 연구계획서 작성, 실험실 연구실습, 논문작성법 / 수업방법: 강의, 협동학습, 팀티칭, 실험실습, 멘토링
필수의료인재 트랙	필수의료개론-입문-심화, 필수의료실습 I~IV 등 / 의료역사, 지역사회 건강, 소아응급실습, 1차의료 실습 / 수업방법: 강의, 토의, 현장방문실습, 사례연구
지역사회의료인재 트랙	의료정책과 제도, 지역사회의학 및 공공보건의료 입문-심화-실습 I~IV 등 / 공공의료사업기획, 지역통합돌봄실습, 취약계층 지원실습 / 수업방법: 강의, 토의, 현장실습, 정책연구, 프로젝트 기반 학습
글로벌 리더 트랙	의료경영학, 의료팀의 비밀, 변화를 이끄는 리더십, 글로벌 리더되기, 글로벌 리더십 입문(명사특강), 국제학회 참여와 글로벌 연구역량, 글로벌 리더십 프로젝트 및 실습 I·II / 리더십, 의료경영학, 글로벌 리더의 이해, 시스템사고, 조직문화 / 수업방법: 강의, 토의, 사례연구, 해외현장실습, 멘토링

<표 11> P대학 트랙별 교육과정 주요 내용(안)

마. 지속적 진로탐색 프로그램(안)

P대학은 1학년 '의학적 자기탐색과 직업정체성 형성'부터 6학년 '진로 확정과 실행'까지 학년별 진로탐색 목표를 설정하고, 필수과정(의사와 리더십, 사회봉사, 자기계발 I~Ⅲ, 펜토미노 트랙별 심화과정, 임상실습)과 선택과정('의료 직무 탐험대: 연구실에서 진료실까지', '커리어 콜라보: 함께 만드는 진로 탐구', 트랙별 진로코칭 세션, 진로 로드맵 설계 워크숍, 'Deep Dive: 나만의 길 찾기', 졸업생 멘토 네트워킹 세션), 상시 프로그램(면담조 상담, 펜토미노 드림 포트폴리오)을 연계한 지속적 진로탐색 프로그램을 설계하였다.

6. 「학생 맞춤형 교육과정 개발과 운영 가이드북」 제작

연구팀은 앞서 도출한 학생맞춤형 교육과정 개발 자료, EP 교육과정 편성 자료, Career Path Coaching 자료를 종합하여, 각 대학이 실제 운영 문서 수준으로 활용할 수 있는 「학생 맞춤형 교육과정 개발과 운영 가이드북(Track·Enrichment Period·STEPS 진로코칭 운영안)」을 제작하였다. 가이드북은 의과대학 학장단, 교육과정위원회, Track 책임교수, 코칭 교수, 학생지원 및 학사 행정 담당자를 활용 대상으로 하며, 트랙별 6과목 체계, 9주·18주·28주 EP 프로그램 예시, 단계별 STEPS 코칭 전략을 포함하여 실제 편성표와 운영안 작성에 바로 활용할 수 있도록 구성하였다. 가이드북은 총론, 편성모델(1-4안), 특성화 Track 운영 개요 및 Track별 운영 가이드, EP 운영 가이드, STEPS 모형 기반 설계, 코칭 운영 가이드, 운영 여건 및 지원 체계, 평가 및 관리, 표준 서식 예시의 10개 장으로 구성된다.

가. 교육과정 편성(안)의 성격과 공통 구성 요소

가이드북과 편성표 종합 보고서는 통합성, 연속성, 학생 맞춤형, 지역기반 임상실습, 의과학연구의 다섯 가지 설계 원칙에 따라, 학생의 진로·적성에 따른 맞춤형 이수 경로를 정규 교육과정 안에 구조화한 교육과정 편성(안) 4종(1안~4안)과 그 해설을 제시하였다. 1안~4안은 상호 배타적인 대안이 아니라 대학의 미션·졸업 성과·운영 여건과 발전 단계에 따라 선택·변형하거나 순차적으로 이행할 수 있는 로드맵(1안 → 4안)이며, 모든 안은 공통 교육과정(통합교육·통섭교과·지역사회기반 교과·의료현장의 이해)을 동일하게 유지하고 학생 맞춤형 요소인 Track 수와 EP(Enrichment Period) 기간에서만 차이를 가진다. Track 탐색(1~3학년) → EP 설계·수행(4학년) → 통합 성찰·진로 전환(5~6학년)의 종단 흐름은 STEPS 진로코칭과 포트폴리오가 연결한다.

(학년 단계 구조와 공통 교과) 편성표의 학년 단계(Phase) 구조와 전 학년 공통 교과의 배치는 다음과 같다.

단계	내용
Phase 1 (1~2학년)	일반교양·의학입문·통합교육 진입과 조기임상노출을 통한 학습 동기·진로 탐색의 맥락 형성 단계. 1학년은 신입생 세미나(인성·대학적응, STEPS Screening의 출발점)와 의학입문(기초·임상·의학교육 교원 합동 강의)이 통섭교과의 역할을 담당
Phase 2 (3~4학년)	통합교육 심화와 선택과목·Track 집중 이수, 4학년 EP 수행을 통한 진로 몰입 단계. EP 종료 후 4학년 겨울 임상실습 전 준비교육(술기·환자안전·실습 오리엔테이션)을 거쳐 5학년에 진입
Phase 3 (5~6학년)	기본·선택임상실습, 학생주도외래, 학생인턴 중심의 실습 단계. Track은 금요일 오후에 병행 이수하며, 3·4안에서는 6학년 2학기 학생인턴 이후 EP Ⅱ(7주)를 배치

<표 12> 편성표의 학년 단계(Phase) 구조

공통 교과	편성 내용(모든 안 동일)
통합교육	2~4학년 정규 학기의 중심 교과. 기초·임상의학을 장기·계통 단위로 통합한 핵심 필수 과정으로 모든 학생이 공통 이수
통섭교과	인문·사회·윤리·의사소통을 의학과 연결하는 교과(예: 우리 삶의 Big Ideas, 사회의 법과 제도와 건강, 휴머니즘과 의학, 서사의학, 의료법과 법의학). 1학년 신입생 세미나·의학입문 → 2~4학년 통섭교과 → 5~6학년 1학점 병행으로 전인적 전문성의 축을 형성. 의료인문학 교과목은 통섭교과 내 개설을 기본으로 하되 특성화 Track(예: 의학교육자 Track) 또는 선택과목으로도 개설 가능하며, 개설 형태는 각 대학의 미션·비전과 교육성과에 따라 자율 설계
지역사회기반 교과목	1학년 리빙랩 → 2~4학년 보건의료체계·지역사회기반 의료 리더십과 의사소통·지역보건사업 기획 → 5학년 매 학기·6학년 1학기 LIC형(학생주도외래 연계)으로 단계적 심화되는 지역기반 실습 축
의료현장의 이해 (조기임상노출)	1~4학년 매 학기 하단 띠로 배치. 응급의료(1학년) → 내과계(2학년) → 외과계·진단/치료/재활(3학년) → 시뮬레이션·지역/공공의료기관(4학년) 순으로 현장 경험을 확대하며, Track·EP 선택의 경험적 기반이자 임상실습의 단계적 준비 과정으로 기능
선택과목	3학년 매 학기 말(Track 집중기간 병행)·4학년 1학기 말(4안은 3학년만 편성)에 배치되는 소단위 교과. Track 과목과 연계하거나 EP 사전 준비 학습으로 활용
평가·전환 장치	2·3학년 2학기 말과 4학년 1학기 말 진료수행시험, 6학년 초 진료수행시험(1학점), 5학년 말·6학년 1학기 말 종합시험, 6학년 말 임상종합평가로 단계별 역량을 확인. 4학년 겨울(EP 종료 후) 임상실습 전 준비교육을 거쳐 5학년 기본임상실습 진입
임상실습·학생인턴	5학년 기본임상실습·학생주도외래(통섭교과 1학점 병행) → 6학년 선택임상실습·학생주도외래(LIC형 병행)·학생인턴으로 이어지는 Phase 3 실습 축

<표 13> 전 학년 공통 교과의 편성 내용

(학생 맞춤형 요소) 학생 맞춤형 요소는 다음의 세 가지로 구성된다.

Track: 학기 말(방학 직전) 집중 배치되는 진로 특성화 교과 계열. 1학년 2학점·2주 → 2~3학년 3학점·3주 집중 → 5~6학년 금요일 오후 병행으로 한 Track당 6과목을 이수한다. 1~2학년의 Track은 진로 확정이 아닌 탐색·자기이해 단계이며, 6개 특성화 Track(의사과학자·지역사회의료·미래의료·디지털헬스·국제보건·의료정책/경영·의학교육자) 중에서 운영한다.

EP(Enrichment Period): 이수한 Track을 바탕으로 진로·적성에 맞는 활동을 수행하는 몰입 구간. 단순 선택실습이 아니라 사전 설계(진로코칭, Bridge Time)–집중 수행–중간발표–성과 포트폴리오·성찰의 중단 구조를 필수로 하며, 안에 따라 9주 → 18주 → 18주+7주 → 28주+7주로 확장된다.

여름방학 정렬: 학년별 여름방학(8·6·6·4·6주)의 시작 시점을 같은 주에 맞추어 배치함으로써 방학 직전 Track 집중과목, EP·지역사회 현장활동, 선후배 연계 프로그램을 동시 운영하고 기관 협약·교수 배치·학생 이동의 운영 효율을 확보한다.

(Track 배치 구조) Track 배치 구조는 2개 Track을 운영하는 1·2안과 4개 Track을 운영하는 3·4안으로 구분된다. 3·4안은 1~2학년에 4개 Track을 모든 학생이 공통 이수하는 "Track 공통" 단계(공통①~④), 3학년에 학생이 선택한 2개 Track을 집중 이수하는 "기본선택" 단계(기본선택1·2), 5~6학년 금요일 오후에 이를 이어 심화하는 "심화선택" 단계(심화선택1·2)의 3단계 이수 구조(확산 → 수렴)를 편성표에 명시하였다.

학년	1·2안 1학기 말 (여름방학 직전)	1·2안 2학기 말 (겨울방학 직전)	3·4안 1학기 말 (여름방학 직전)	3·4안 2학기 말 (겨울방학 직전)
1학년	Track ①-1 (2학점·2주)	Track ②-1 (2학점·2주)	Track 공통①-1 (2학점·2주)	Track 공통②-1 (2학점·2주)
2학년	Track ①-2 (3학점·3주)	Track ②-2 (3학점·3주)	Track 공통③-1 (3학점·3주)	Track 공통④-1 (3학점·3주)
3학년	Track ①-3 (3학점·3주)	Track ②-3 (3학점·3주)	Track 기본선택1·2 (3학점·3주)	Track 기본선택2·2 (3학점·3주)
4학년	— (선택과목·진료수행시험)	EP 9주(1안) / 18주(2안)	EP I (4안: I-A 1학기 10주)	EP I 18주(3안) / 4안: I-B 18주
5학년	Track ①-4·②-4 (금요일 오후)	Track ①-5·②-5 (금요일 오후)	Track 심화선택1·3 (금요일 오후)	Track 심화선택2·3 (금요일 오후)
6학년	Track ①-6·②-6 (금요일 오후)	— (학생인턴·임상종합평가)	Track 심화선택1·4·2·4 (금요일 오후)	EP II 7주 (심화·특성화실습·캡스톤)

<표 14> Track 배치 구조 — 2개 Track(1·2안) vs 4개 Track(3·4안)

나. 편성(안) 1안~4안의 구조와 해설

네 가지 편성(안)의 핵심 차이는 Track 수(2개 → 4개)와 EP 기간(9주 → 18주 → 18주+7주 → 28주+7주)의 확장 축 위에 놓이며, 요약하면 다음과 같다.

구분	명칭·핵심 구조	편성 내용	적용 대상 및 학생 이수 경로 요약
1안	Track 2개 + EP 9주 (표준 기본형)	4학년 2학기 EP 9주 배치, Track → EP 연계, 5학점 내외	맞춤형 교육과정을 처음 도입하는 대학의 진입 안. 2개 Track에서 1개 EP 선택
2안	Track 2 또는 4개 + EP 18주 (심화 확장형)	EP 18주(EP-A/EP-B 9주+9주 분할 또는 단일 프로그 램), 복수 Track 가능, 10학점 내외	EP 운영 경험과 협력기관 기반이 형성된 대학. 2개 또는 4개 Track에서 1~2개 EP 선택
3안	Track 4개 + EP I 18주 + EP II 7주 (전주기 이중 배치형)	4학년 EP I 18주 + 6학년 2학기 EP II 7주, 전주기 포트폴리오	전담 운영조직과 안정적 행정 지원체계를 갖춘 대학. 4 개 Track에서 1~2개 EP 선택
4안	Track 4개 + EP I 28주 + EP II 7주 (최상위 확장형)	4학년 1년간 EP I 28주(I-A → 여름방학 → I-B) + 6학년 EP II 7주, 전주기 포트폴리오	Track 책임교수·협력기관·코칭 인력이 안정화된 대학. 4 개 Track에서 1~2개 EP 선택(14주+14주 또는 28주)

<표 15> 교육과정 편성(안) 1안~4안의 핵심 차이 요약

(1안: Track 2개 + EP 9주) 1안은 Track ①·② 2개를 1학년(①-1·②-1, 2학점·2주) → 2~3학년(①-2·②-2·①-3·②-3, 3학점·3주 집중) → 5~6학년 금요일 오후 (①-4~⑥·②-4~⑥)로 종단 배치하고, 4학년 2학기에 9주(5학점 내외)의 EP를 배치하여 이수한 Track ①·② 중 하나를 바탕으로 진로·적성에 맞는 활동을 수행하는 표준 기본형이다. 1~3학년 매 학기 말(여름·겨울방학 직전)에 Track 집중 구간이 배치되어 정규 통합교육과 충돌 없이 탐색이 누적되고, 3학년 학기 말 선택과목이 Track과 연계되어 EP 사전 준비 학습으로 기능한다. 5학년에는 지역사회기반 교과목(LIC형)·학생주도외래·통섭교과가 병행되며 Track은 금요일 오후로 이동하여 실습 부담과 균형을 유지한다.

1안은 Track 탐색을 실제 몰입 활동으로 전환하는 첫 번째 표준 구조로 임상실습 전 진로 점검과 학습동기 재구성의 계기를 마련하며, 9주 내 실행 가능한 연구보조·지역사회 활동·창의 프로젝트 중심으로 운영한다. 코칭은 Track 탐색-EP 설계-실행-임상 연계 성찰의 흐름으로 운영하며, 맞춤형 교육과정을 처음 도입하는 대학의 진입 안으로 적합하고 이후 2안~4안으로의 단계적 확장 기반이 된다. 학생 관점에서는 1학년에 Track ①-1(1학기 말)·②-1(2학기 말)을 한 학기씩 수강하여 두 Track을 모두 탐색하고, 2·3학년에 각 Track의 두 번째·세 번째 과목을 학기별로 이어서 수강한 뒤, 4학년 1학기에 Track 1개를 선택하여 진로코칭과 함께 EP 계획을 수립하고 4학년 2학기에 EP(9주)를 수행하며, 5~6학년에 금요일 오후 Track 과목으로 Track을 완성하고 EP 경험을 공유(발표·성찰)·심화한다.

(2안: Track 2 또는 4개 + EP 18주) 2안은 Track 편성을 1안과 동일한 ①·② 2개 기본 구조로 유지하되(4개 운영 시 3안의 배치를 준용), 4학년 2학기 전체를 EP 18주(10학점 내외)로 재편하여 장기 프로젝트 수행이 가능한 시간 구조를 확보한 심화 확장형이다. EP는 EP-A/EP-B 분할(9주+9주) 또는 단일 프로그램(통합 18주)으로 운영할 수 있으며, 진로코칭(Bridge Time)·중간발표·성과 포트폴리오를 필수 요소로 한다. EP-A/EP-B 분할형은 전반부 수행 후 중간 성찰을 거쳐 후반부에 심화·수정하거나 다른 Track과 조합하는 유연성을 가지며, 통합형은 장기 프로젝트 관리를 가능하게 한다.

2안에서는 복수 Track 비교·선택과 Track 간 융합 프로젝트(예: 지역사회의료+의료정책, 의사와학자+디지털헬스) 수행이 가능하고, 산출물·발표·성찰보고서를 포함한 깊이 있는 심화 학습을 구현하며, Track 책임교수·진로코치·기관 멘토의 다층적 코칭 체계가 필요하다. EP 운영 경험이 축적되고 협력기관 기반이 형성된 대학의 심화 확장 안으로 적합하다. 학생은 4학년 1학기에 이수한 Track 중 1개 또는 2개를 선택하여 EP 계획을 수립하고, 4학년 2학기 EP(18주)에서 9주+9주 분할 시 1개(단일 프로그램) 또는 2개의 EP를 수행할 수 있으며, Phase 3은 1안과 동일하게 진행한다.

(3안: Track 4개 + EP I 18주 + EP II 7주) 3안은 1학년에 Track ①·②(각 2학점·2주), 2학년에 Track ③·④(각 3학점·3주)를 개설하여 1~2학년에 4개 Track을 모두 경험한 뒤 3학년부터 학생이 선택한 2개 Track(기본선택1·2)으로 수렴하여 집중 이수하고 5~6학년 금요일 오후에 심화선택1·2로 이어가는 "확산 → 수렴" 구조에, 4학년 2학기 EP I 18주(EP-A/EP-B 또는 단일 프로그램)와 6학년 2학기 EP II 7주(Track 심화·특성화실습·연구발표/캡스톤)를 이중 배치한 전주기 이중 배치형이다. 6학년 학생인턴 이후 EP II가 배치되어 임상실습·학생인턴 경험을 바탕으로 전공 선택과 졸업 후 경로를 최종 구체화한다.

3안은 4학년 심화 몰입(EP I)과 졸업 전 전환(EP II)의 이중 배치 구조로 입학-졸업 전주기 진로 발달 체계를 구현하며, EP I 산출물과 EP II 성찰을 졸업 포트폴리오로 연결하기에 최적이고 포트폴리오 기반 진로코칭 결합에 가장 적합한 구조이다. 전담 운영조직과 안정적 행정 지원체계가 갖추어진 대학에 적합하다. 학생은 4개 Track을 모두 탐색한 뒤 2개로 수렴하여 집중 이수하고, EP I은 2안과 동일하게 1개 또는 2개 프로그램으로 수행하며, 6학년 2학기 EP II(7주)에서는 첫 번째 EP의 Track을 그대로 심화하거나 새로운 Track의 EP를 경험할 수 있다.

(4안: Track 4개 + EP I 28주 + EP II 7주) 4안은 3안과 동일한 4개 Track 구조(1학년 ①·②, 2학년 ③·④, 3학년~ 선택1·2)를 유지하면서, 4학년 전체를 EP I 28주로 편성한 최상위 확장형이다. EP I은 4학년 11주차부터 I-A(Track 택1 심화, 10주) → 여름방학(6주, 필수 포함) → I-B(다른 Track 택1 또는 I-A 연장, 18주)의 연속 몰입 구조로, 연구·지역사회·국제보건 등 학기 단위를 넘는 장기 몰입이 가능하며, I-A와 I-B의 조합 방식에 따라 단일 분야 심화형(I-A 연장)과 융합형(다른 Track 택1)을 학생별로 설계할 수 있다. 6학년 2학기 EP II 7주는 3안과 동일하다. 4학년에는 통섭교과·선택과목이 편성되지 않고 지역사회기반 교과목은 1학기 EP I 진입 전에 이수한다.

4안은 학위 연계형 연구, 현장 몰입형 경험까지 수용하는 최상위 확장 구조로 포트폴리오 기반 성장관리와 전주기 진로코칭의 결합이 필수이며, Track 책임교수·협력기관·코칭 인력이 안정화된 대학에서 1안~3안 운영 경험 위에서 도달하는 로드맵의 최종 단계이다. 기본선택·심화선택의 이수 내역이 EP I·II의 Track 선택과 심화 방향 설정의 근거가 된다. 학생은 4개 Track 중 1개 또는 2개를 4학년 1학기에 선택하고 4학년 11주차부터 EP I을 시작하며, 기간 중 1개(I-A 연장 심화형) 또는 2개(융합형)의 Track을 선택하여 EP를 경험한 뒤 6학년 2학기 EP II(7주)에서 두 번째 EP를 수행한다.

(편성(안) 선택의 기준) 어느 안을 선택하더라도 공통 교육과정의 골격(통합교육·통섭교과·지역사회기반 교과·조기임상노출·임상실습 축)과 여름방학 정렬 원칙은 동일하게 유지되므로 편성(안) 간 이행 시 학사구조의 연속성이 보장된다. 대학은 미션·졸업성과·교수 인력·협력기관·행정 지원 역량을 기준으로 출발 안을 선택하고 단계적으로 이행할 수 있으며, 편성표의 세부 주차·학점은 각 대학의 학사 일정·운영 여건에 따라 조정될 수 있다.

다. 특성화 Track별 운영 가이드: 6과목 체계와 STEPS 코칭

가이드북은 Track을 공통 교육과정을 대체하는 장치가 아니라 공통 역량 위에 학생별 진로 심화를 더하는 장치로 규정하고, 모든 Track이 대학의 졸업성과와 정합성을 가지며 나선형(spiral) 구조를 갖추고 EP·코칭 체계와 연동되도록 하였다. 6개 특성화 Track(의사과학자, 지역사회의료, 미래의료·디지털헬스, 국제보건·글로벌헬스, 의료정책·경영, 의학교육자 양성) 각각에 대해 1~4학년에 걸쳐 점진적으로 이수하고 EP 과목을 핵심 몰입 교과로 포함하며 성찰·캡스톤·포트폴리오 성격의 과목으로 마무리하는 「한 Track당 6과목 체계」와 STEPS 코칭 전략을 제시하였다. 6개 특성화 Track의 운영 목적·핵심 역량과 Track별 6과목 구성은 다음과 같다. 각 Track은 1~3학년 학기 말 집중(2·3·3주) → 4학년 1학기 선택과목 연계 → 4학년 EP 몰입 수행 → 5·6학년 금요일 오후 이수의 흐름으로 운영된다.

Track	운영 목적	핵심 역량
의사과학자	기초 의과학 지식과 임상 문제의식을 연결하여 연구 설계·데이터 해석·논문 작성까지 수행하는 의사과학자형 학습 경로	연구지식·비판적 사고·데이터 해석·연구윤리·학술 의사소통
지역사회의료	지역사회·공공보건 맥락에서 의료인의 역할을 이해하고 지역문제 해결 역량과 사회적 책무성 강화	사회적 책무성·공공보건 이해·일차의료 실천·지역자원 연계·IPE 협업
미래의료·디지털헬스	디지털 리터러시·데이터 활용 역량으로 미래 의료환경 변화에 대응하는 문제해결형 경로	디지털 리터러시·AI 활용·데이터 해석·융합적 사고·기술-의료 문제 정의
국제보건·글로벌헬스	세계 보건 이슈와 국제보건체계를 이해하고 다문화 맥락에서 글로벌 헬스 리더십을 기르는 경로	글로벌 리더십·개방성·비교체계 분석·타문화 소통·국제 프로젝트 수행
의료정책·경영	보건의료체계·제도·경영·거버넌스 이해를 바탕으로 시스템 수준의 문제해결 역량 강화	시스템 사고·정책 분석·조직 이해·보건경제 기초·리더십
의학교육자 양성	의학교육자의 역할과 정체성을 탐색하고 스피치·글쓰기·마이크로티칭·교수법 실천 역량을 단계적으로 개발	의학교육자 정체성·학습자 이해·교육적 의사소통·의학 글쓰기·수업 설계·교수법·피드백과 성찰

<표 16> 6개 특성화 Track의 운영 목적과 핵심 역량

Track	1학년(2주)	2학년(3주)	3학년(3주)	4학년 1학기	4학년 EP	5·6학년
의사과학자	의과학 입문과 연구윤리 (연구자 정체성·연구윤리 기초)	실험설계와 의학통계 기초 (연구 질문·변수·통계 해석)	논문 읽기와 비판적 고찰 세미나 (Journal club)	Lab Rotation과 연구방법론 (연구실 경험·분야 탐색)	Research Immersion EP (집중 연구·데이터 생성·중간 발표)	의학심화연구와 논문작성 (포스터·구두 발표·원고 초안)
지역사회의료	지역사회 보건의로 이해 (지역 보건문제·건강결정요인)	일차의료와 공공보건 정책 (보건소·공공병원·지역보건 정책)	취약계층 건강과 통합돌봄 (취약계층 지원·통합돌봄 모델)	지역보건사업 기획 실습 (건강문제 선정·프로젝트 설계)	Field Camp EP (취약지 현장활동·방문보건·건강증진)	지역사회·공공의료 LIC (장기 추적형 실습·성찰 세미나)
미래의료·디지털헬스	디지털 리터러시와 미래의학 입문 (AI·데이터·XR·디지털치료제)	의료 데이터 읽기와 파이썬 기초 (기초 코딩·데이터 다루기)	의료 인공지능과 머신러닝 개론 (원리·의료 적용 사례)	빅데이터 분석과 XR 실습 (데이터 분석 PBL·XR 실습)	부트캠프·창의혁신 EP (프로토타입·해커톤·산학 프로젝트)	미래의료 캡스톤 디자인 (의료문제 해결 모델 발표)
국제보건·글로벌헬스	국제보건과 WHO 입문 (글로벌 보건 의제·국제기구)	국가별 보건의로 체계 비교 (시스템 차이 비교 분석)	감염병 대응과 국제 구호실무 (국제 보건 현장 업무·윤리)	영어 의료 커뮤니케이션·프로젝트 (해외 활동 소통·계획)	Global Project EP (해외 교류·국제기구 연계·현장 프로젝트)	글로벌 보건 프로젝트 세미나 (활동 보고서·장기 커리어 비전)
의료정책·경영	의료시스템과학 입문 (보건의료체계·HSS 관점)	법·제도·건강의 이해 (의료법·윤리·정책 구조)	보건경제와 병원경영 기초 (수가·재정·조직관리·서비스 운영)	정책분석 방법론과 사례 세미나 (정책문서 분석·사례 토의)	Policy Internship EP (정책기관·공공기관·병원행정 실무)	거버넌스·정책제안서 작성 (정책 브리프·경영 분석보고서)
의학교육자	의사의 다양한 직역과 의학교육자 이해 (교육자 정체성)	교육 커뮤니케이션과 스피치 (설명·질문·경청·발표·피드백)	의학 글쓰기와 마이크로라이팅 (학습자료·교육용 글·피드백 문안)	학습자 이해와 의학교육 교수법 (성인학습·소그룹 수업·평가)	마이크로티칭·Peer Teaching EP (수업 설계·시연·동료 튜터링)	Teaching Portfolio·교육실천 세미나 (교육 철학·수업 사례·향후 경로)

<표 17> 6개 특성화 Track별 6과목 구성(편성표 Track ① 기준)

6개 Track별 9주형 EP 운영 흐름과 대표 산출물은 다음과 같이 표준화하였다.

Track	9주형 EP 운영 흐름	대표 산출물
의사과학자	연구윤리·통계 준비 → 연구 수행 → 분석·정리 → 발표·성찰	포스터, 연구초록, 데이터 요약
지역사회의료	지역 브리핑 → 기관 활동 → 사례분석 → 결과 정리·발표·성찰	사례보고서, 지역건강 프로젝트 결과물
미래의료·디지털헬스	문제정의 → 데이터/코딩 실습 → 시제품 → 테스트 → 데모데이	프로토타입, 발표자료, 기술 메모
국제보건·글로벌헬스	오리엔테이션 → 팀 프로젝트 → 전문가 멘토링 → 정책문서 작성 → 포럼	정책제언서, 팀 프로젝트 보고서
의료정책·경영	제도 이해 → 기관 실무 → 자료 분석 → 브리프 작성 → 발표	정책 브리프, 경영분석 보고서
의학교육자 양성	교수법 워크숍 → 튜터링 설계 → 교육자료 제작 → 마이크로티칭 → Teaching reflection	수업안, 교육자료, 성찰 저널

<표 18> Track별 9주 집중 수행형 EP 운영안 요약

라. Enrichment Period(EP) 운영 가이드

EP는 학생이 Track 학습을 실제 경험과 산출물로 전환하는 집중 학습 구간으로, 단순한 선택실습이 아니라 Track 선택, 진로코칭, 포트폴리오 평가를 연결하는 학생 맞춤형 교육과정의 핵심 운영 장치이다. 가이드북과 편성표 종합 보고서는 EP 운영 유형을 4주형, 9주형(1안), 18주형(9주+9주 또는 통합, 2안·3안 EP I), 28주형(Extended EP, 4안 EP I), 졸업 전 전환형 EP II(7주, 3안·4안)로 구분하고, 기간이 달라져도 공통적으로 자기진단, 계획서 승인, 지도교수·기관 배정, 중간점검, 최종 발표, 포트폴리오 제출을 포함하도록 하였다.

운영 유형	시기	적합한 목적 및 특징	학점 예시
4주형	짧은 블록 또는 사전 탐색 기간	Track 적합성 확인, 입문, 파일럿 경험. 문제정의·현장 관찰·역할 이해에 초점	2~3학점
9주형 (1안)	4학년 2학기 EP 또는 방학·학기 중 집중 블록	기본형 EP, 집중 실습, 단기 프로젝트 수행. 준비-수행-정리-성찰 포함	5학점 내외
18주형 (2안·3안 EP I)	4학년 2학기 독립 학기	심화 프로젝트, 복수 Track 조합, 한 학기 몰입. 단일 18주 몰입 또는 EP-A 9주+EP-B 9주 조합	10학점 내외
28주형 (4안 EP I, Extended EP)	4학년 11주차~2학기 말(I -A 10주 → 여름 방학 6주 → I -B 18주)	장기 연구·현장실습·글로벌·정책·교육 프로젝트, 학위 연계형 연구. 장기 포트폴리오·캡스톤 연결	12학점 이상 또는 분산학점
EP II 7주 (3안·4안)	6학년 2학기 학생인턴 이후	졸업 전 전환형 EP. Track 심화·특성화실습·연구발표/캡스톤, 학생인턴 이후 진로 확정, 포트폴리오 정리, 전공 선택 상담, 졸업 후 경로 설계. 운영 절차는 9주형을 기준으로 7주로 압축	4학점 내외

<표 19> EP 운영 유형별 기본 구조

확장형 EP(2·3·4안)의 운영 모형별 세부 구조와 적합한 경우, 유의점은 다음과 같다.

운영 모형	세부 구조	적합한 경우	유의점
단일 Track 18주 몰입형 (2안·통합형)	1~2주 준비 → 3~14주 핵심 수행 → 15~18주 분석·심사	연구·장기 현장실습·시제품 개발	4~5주 단위 중간점검 필수
9주+9주 복수 Track 조합형 (2안·분할형)	전반부 Track A → 중간 성찰 → 후반부 Track B	두 진로 분야를 비교·연계·융합하려는 학생	두 Track 최소 성과기준 별도 설정
EP I 18주 + EP II 7주 (3안)	4학년 EP I 18주 → 5~6학년 임상실습·학생인턴 → 6학년 EP II 7주	임상 경험 후 졸업 전 진로를 확정·성찰하려는 학생	EP I 산출물-EP II 성찰의 포트폴리오 연속성 확보
EP I 28주 + EP II 7주 (4안·Extended EP)	4학년 EP I 28주(주/부 Track, 학위 연계 가능) → 6학년 EP II 7주	장기 연구·현장 몰입, 학위 연계를 희망하는 학생	협력기관·코칭 인력 안정화와 전담 운영 조직 필요

<표 20> 확장형 EP 운영 모형 비교(2·3·4안)

※ 가이드북의 EP 운영 모형 선택도에서 "1년형(Extended EP)"은 편성표 4안의 EP I 28주(I-A → 여름방학 → I-B)로 구현되며, 6학년 EP II(7주)는 3안·4안의 졸업 전 전환형 EP로 배치된다.

EP 평가는 사전 승인-수행 중간-최종 심사-사후 추적의 4단계로 운영하며, 평가 영역과 권장 비중은 사전 계획의 적절성 10%, 수행 과정과 참여도 25%, 중간점검 및 수정 능력 15%, 최종 산출물의 완성도 30%, 성찰 보고서와 포트폴리오 20%로 제시하였다. 면담은 사전·중간·종료 각 1회를 기본으로 하고, 18주형과 1년형은 4주 또는 9주 단위 추가 면담을 권장한다. e-Portfolio는 단순 보관이 아니라 학생의 질문-경험-진로계획 조정을 누적적으로 추적하는 종단 도구로 운영한다.

마. STEPS 모형에 따른 학생 맞춤형 교육과정 설계

가이드북은 학생 맞춤형 교육과정이 단순히 Track과 EP를 많이 마련하는 수준을 넘어, 학생의 자기이해-목표 설정-실행-성찰을 일관된 구조 속에서 지원하도록 STEPS 모형을 설계 틀로 제안하였다. STEPS는 Screening(학습자 초기 진단 및 자기이해 기반 교육설계), Thinking(학습 환경의 구조화와 지원 자원 체계 구축), Expressing(학습 목표 명료화와 맞춤형 학습경로 설계), Performing(자기주도적 학습 실행 시스템), Strengthening(성찰 기반 지속 성장 지원 및 피드백 시스템)의 다섯 단계로 구성되며, 코칭 장면에서만 쓰이는 도구가 아니라 교육과정 설계, 교수 역할 분담, 학교 지원 체계 정비에 동시에 적용되는 운영 프레임이다.

단계	주요 설계 요소	기대 산출물
Screening	입학 초기 진단, 학습특성 분석, 정서 지원, 자기주도학습 점검	자기진단 결과, 개인 특성 프로파일, 초기 상담 기록
Thinking	맞춤형 학습환경, 공식·비공식 멘토링, 정기 면담 구조, 자원 연계	지원 계획, 멘토·교수 매칭, 학생 지원 지도
Expressing	목표 설정 워크숍, Track 설명회, 선택과목 조합, EP 설계 지도	학습 목표서, Track 선택 계획, EP 설계안
Performing	실행 가이드라인, 중간 점검, 피드백, 선택형 활동 운영	수행 기록, 중간 보고서, 수정 계획서
Strengthening	포트폴리오, 정기 평가, 개별 피드백, 후속 진로 설계	최종 포트폴리오, 성찰 보고서, 후속 학습·진로 계획

<표 21> STEPS 교육과정 설계 체크리스트 요약

학년별 우선 적용 단계는 1학년 Screening 중심(입학 초기 진단, 탐색 세미나), 2학년 Thinking-Expressing 중심(Track 탐색, 선택과목 조합, 목표 설정), 3-4학년 Performing 중심(EP 설계·수행, 중간점검, 산출물 작성), 5-6학년 Strengthening 중심(포트폴리오 통합, 진로 확장, 후속 계획)으로 제시하였다.

바. STEPS 기반 진로코칭 운영 가이드

STEPS 진로코칭은 단발성 상담기법이 아니라 Track 선택, EP 설계, 포트폴리오 축적, 졸업 전 진로 전환까지를 연결하는 교육과정 지원 체계로 정의된다. 학년별 코칭은 1학년 자기이해와 탐색(흥미·가치·강점·학습 습관의 언어화), 2학년 구조화와 Track 선택 준비('왜 이 Track이 현재의 나와 맞는가' 설명 지원), 3~4학년 EP 설계와 실행(목표-Track 정합성, 준비 학습, 기관·지도교수·산출물 점검 및 수행 중 중간점검), 5~6학년 통합 성찰과 진로 확장(포트폴리오 통합, 전공 선택·연구 지속·지역·정주·국제 활동·교육 활동 등 후속 경로 연결)의 흐름으로 운영한다. 모든 Track은 사전 진단-계획서 작성-수행 중 점검-사후 성찰의 4단계 코칭 프로토콜을 공통 적용하되, Track 특성에 따라 점검 항목을 달리 설정한다. 코칭 교수는 질문을 통해 학생의 판단 근거를 분명히 하도록 돕는 촉진자이자 다른 지원 체계로 연결하는 조정자로 규정하고, STEPS 단계별 운영 원리, 질문 중심 면담과 피드백 기술, Track별 진로 특성·EP 사례, 학생 위기 징후 발견과 연계 절차, 코칭 기록과 포트폴리오 기반 평가의 다섯 범주로 교수개발 내용을 제시하였다.

사. 운영 여건·지원 체계 및 평가·관리

가이드북은 학생 맞춤형 교육과정 운영에 필요한 최소 여건을 다음과 같이 정리하였다.

영역	핵심 내용	최소 확보 요소
인프라	코칭 공간, Track 세미나실, e-Portfolio	면담 공간, 발표 공간, e-Portfolio 시스템
학사제도	Track 선택·변경, EP 신청, 학점 인정	운영 규정, 승인 절차, 이수 기준
교수 인력	Track 책임교수, 코칭 교수, 지도교수	역할 분담, 교수개발, 실적 인정
학생 지원	설명회, 상담, 정서 지원, 진로 지원	학생지원센터, 사례관리, 정보 제공

<표 22> 학생 맞춤형 교육과정 운영 여건 요약

평가는 출석 확인이나 지식시험 중심이 아니라, 학생이 무엇을 계획하고 수행했으며 그 경험을 어떻게 성찰하고 다음 단계와 연결하는지를 확인하는 성과 기반 방식으로 설계하였다. 공통 평가 기준(목표의 명확성, 수행의 충실성, 성찰의 깊이, 전문직업성, 협업 태도)과 Track별 특화 기준(연구 설계, 지역문제 해결, 기술 구현, 정책 분석, 교육 실행 등)을 병행하며, 운영 점검 항목으로 Track 신청 분포, EP 참여율, 중도 변경 비율, 코칭 실시율, 외부기관 매칭 현황, 학생 만족도, 졸업 전 진로 연계 정도 등을 두어 차년도 운영 조정으로 환류하도록 하였다. 아울러 제도 운영의 일관성을 위해 Track 신청서, 자기진단지, 코칭 면담 기록지, EP 계획서, EP 중간점검 기록지, 기관 확인서, EP 최종 성찰 보고서, 포트폴리오 점검표, 이수 확인서 등 9종의 표준 서식 예시를 수록하여 신청-승인-수행-점검-성찰-이수 확인의 전 과정이 연결되도록 하였다.

7. 진로코칭 전략 개발: 문헌고찰과 한국형 진로코칭 체계

STEPS 진로코칭 전략의 이론적·실증적 근거를 확보하기 위하여 연구팀은 국내 의과대학생의 진로 탐색 실태, 코칭의 개념과 효과 근거, 국내외 진로코칭 모형과 가이드라인을 고찰하고, 이를 통합 6년제 교육과정에 적용한 M1-M6 진로코칭 로드맵과 한국형 진로코칭 체계 구축 방안을 도출하였다.

가. 의과대학생 진로 탐색 실태와 진로 지도의 시급성

국내 선행연구에 따르면 한국 의과대학생은 뻘뻘한 교육과정 속에서 자신에게 맞는 전공을 탐색할 여유가 부족하며, 개인의 적성·내재적 동기보다 외재적 요인(부모, 사회경제적 지위, 안정성)에 의해 진로가 결정되는 경향이 뚜렷하다. 의대 입학 동기로 사회적 지위와 안정성을 응답한 비율이 27.6%, 부모의 권유가 입학 결정에 큰 영향을 미쳤다는 응답이 35.6%였으며, 기성 의사의 66.9%가 다른 분야로의 진로 전향을 심각하게 고민한 것으로 보고되었다. 외재적 동기에 의한 입학은 학업 몰입도 저해와 졸업 후 세부 전공 선택 단계의 심각한 진로 미결정(career indecision)·심리적 부적응으로 이어지며, 학부 시절 자아 정체성에 부합하는 전공 탐색 기회의 부재는 수련 과정 생략과 비필수 미용·성형 영역으로의 직행 현상을 심화시켜 국가적 인적 자원 낭비로 귀결된다.

학생 요구조사(가천의대 본과 2학년 설문)에서는 84.8%가 "공식적인 진로 지도가 필요하다"고 응답하였으며, 희망 코칭 주제로 적성에 맞는 전공 선택법, 졸업 후 다양한 커리어 패스, 전공별 업무 내용·의국 분위기·환자군 특성, 기대 수입·여가·해외 진출 가능성, 취업 형태별(임상교수·봉직·개업·연구·창업) 삶의 차이를 제시하였다. 한편 2025년 4월 KEDI 통계 기준 의과대학 교원 1인당 학생 수는 전국 평균 2.1명(국립 3.0·사립 1.8, 최소 0.5~최대 5.9명)으로 개별 맞춤형 코칭에 충분한 교수 자원은 이미 확보되어 있으나, 구조화된 프로그램·표준 가이드라인의 부재로 활용도가 낮고 개별 교수의 사적인 정서적 조언 수준에 머무르고 있어, 대학 차원의 체계적 진로 개입은 더 이상 선택이 아닌 필수 요건임을 확인하였다.

나. 코칭의 개념과 효과 근거

코칭(coaching)은 철저히 결과 지향적(result-oriented)이며 주도권이 학습자(learner-centric)에게 있고, 정해진 기간 동안 목표 달성을 촉진하는 체계적 과정으로 정의된다. 의학교육에서 코칭은 기술적 영역(임상 수행 역량, 직접 관찰·즉각적 피드백; 증거 강도 가장 강함), 비기술적 영역(의사소통·다학제 협업·리더십; 중간), 웰빙·탄력성 영역(번아웃 예방·회복탄력성; 발전 중)의 세 영역에 적용되며, 멘토링과는 관계의 방향과 전달 방식에서 구분된다.

구분	멘토링(Mentoring)	코칭(Coaching)
관계 방향	하향식·모방 중심(선배 → 후배)	수평적·비처방적·비평가적
전달 방식	가치관 전수, 장기적 조언, 정서적 후원	고도로 설계된 질문·자극 → 자기 도출
코치 역할	정답·지혜 제공자	촉진자(facilitator) — 실행 계획 작성을 돕는 사람

<표 23> 멘토링과 코칭의 비교

진로 코칭의 효과는 무작위 대조군 연구로 검증되었다. Fris 등(Erasmus MC·암스테르담 대학)의 RCT(실험군 94명, 대기자 대조군 130명, 8개월간 5회 1:1 코칭)에서 진로 미결정은 심리적 고통을 유의하게 증가시켰으며($\beta=0.20$), 코칭은 ① 진로결정 자기효능감 향상, ② 문제해결 대처 증가($\beta=0.14$)와 역기능적 대처 감소($\beta=+0.25$, 가장 강한 가중), ③ 자아개념 명확성(baseline에서 부정·냉소적이던 하위군에서 극적 향상)의 세 가지 매개 기전을 통해 심리적 고통을 감소시켰다(총 효과 0.17, 95% CI 0.31~ 0.06). 후속 연구(Fris 등, 2025; 2022)는 진로결정 스트레스 감소, 진로결정 자기효능감 향상, 전공 선택 확신 상승을 진로 코칭 효과 평가의 3대 핵심 지표로 제시하였고, Zink 등(2007)은 포괄적 진로개발 프로그램이 학생의 진로계획 서비스 만족도 향상과 관련됨을 보고하여 진로 코칭을 개별 상담이 아닌 교육과정 기반 프로그램으로 설계해야 한다는 근거를 제공하였다.

한편 코칭이 성과 중심·효율성 극대화에만 몰두할 경우 모든 도전 과제에 정량화된 전략과 기술적 해결책만 존재한다는 기술 만능주의적 오류(hidden curriculum)에 빠질 수 있다는 비판을 고려하여, 연구팀은 단기 코칭(계량적 성과·행동 수정·실행 계획·짧은 피드백 루프)과 장기 멘토링(삶의 궤적·직업적 정체성

동행, 가치관·소명의식 형성, 도덕적 모호성을 건디는 힘, 인간 중심적 성찰)을 결합한 이중 축(dual-track) 모델을 지향하였다. "정량화된 성과"와 "전인적 정체성"이 결합되어야 지속 가능한 진로 지도가 완성된다.

다. 국내외 진로코칭 모형과 가이드라인

진로 코칭은 학생이 자신의 흥미·가치·역량·생활양식 선호를 이해하고, 임상실습·연구·지역사회·비임상 진로 경험을 해석하면서 전공 선택과 졸업 후 수련 진입을 준비하도록 돕는 중단적 학습자 지원 체계로 정의되며, 학업코칭·멘토링·어드바이징이 분절되지 않고 학생지원 체계 안에서 다층적으로 통합되어야 한다. 이러한 관점에서 검토한 국내외 주요 모형과 가이드라인은 다음과 같다.

모형·가이드	핵심 구조	본 과제 적용 방향
Hur(2016) 3단계 중단 모형	KJME 28(1). 한국 의대생의 진로 발달을 Crystallization(M1-M2, 자기이해·결정화: self-assessment) → Specification(M3-M4, 구체화·진로계획: career planning) → Implementation(M5-M6, 실행·진로결정: career decision)의 3단계로 구분	학년·교육단계를 가로축, 단계별 목표·핵심 활동·지원체계·교육과정 연계 요소를 세로축으로 배치하는 중단형 로드맵으로 재구성, STEPS 절차와 결합
SCCP(Hur 등, 2018) 체계적 진로코칭 프로그램	KJME 30(1). ADDIE 모형과 의사결정 질문모형(What-Why-How-Where-When-Who-Whom)을 결합하여 학년별 프로그램 매트릭스, 학생용 워크시트, 교수자용 코칭 질문지, 학년별 진로활동 과제표를 산출	학년별 운영 자산(워크시트·질문지·과제표)의 표준 서식 설계에 반영
AAMC Careers in Medicine 4단계 모형	Understand Yourself(자기이해) → Explore Options(선택지 탐색) → Choose Your Specialty(전공 선택) → Prepare for Residency(레지던시 준비)의 학생 행동 단위 모형	국내 적용 시 "자기이해 → 전공·진로 탐색 → Track/EP 선택 → 수련 및 경력 전환 준비"로 재구성
Canadian National Guidelines (Howse 등, 2017)	Academic Medicine 92(11). 대학 차원 운영 5대 필수요소: ① 구조화된 진로 지도 ② 이용 가능한 진로 정보 ③ 선택실습 지도 ④ 레지던시 지원 준비 ⑤ 사회적 책무성	AAMC(학생이 무엇을 해야 하는가)와 보완적으로 대학이 무엇을 갖추어야 하는가를 규정, 운영 여건 6대 영역 설계에 반영
UCSF Career Advising Timeline	Bridges Curriculum-Physician Identity Week와 연계하여 학생의 진로 여정상 위치를 시각화하고 다음 행동을 식별하도록 돕는 교육과정 연계 중단 타임라인	M1(자기이해·조기임상노출) → M2(Track 선택) → M3(EP 계획·실행) → M4(임상실습·포트폴리오) → M5(전공 확정) → M6(경력 전환 설계)의 6년 타임라인으로 변환
Coaching Competency Framework (Wolff 등, 2021)	Academic Medicine 96(Supp 2). 수정 델파이로 도출한 코치 양성 5대 역량: ① 코칭 과정·구조 ② 관계 형성(신뢰·비밀 보장·심리적 안전성·평가권 배제) ③ 코칭 기술(적극 경청·강력한 질문·실행 계획 촉진) ④ 이론·모형 이해 ⑤ 코치 개발(자기성찰·슈퍼비전)	진로코칭 전담교수·Track 책임교수·EP 지도교수 대상 교수 개발 워크숍, 코칭 역량 평가 루브릭, 인증 코칭 풀 구성의 표준 프레임으로 활용

<표 24> 국내외 진로코칭 모형과 가이드라인의 핵심 구조 및 적용 방향

글로벌 선진 의과대학·수련기관의 진로코칭 사례(AAMC CiM 4단계 순환 모델 기반)로는 University of Michigan의 커리어 개발 프로그램(전문 카운셀러 자가진단·임상의 shadowing·매칭 탈락 우려 학생 at-risk plan, 예과 1년~본과 4년 필수 이수), Vanderbilt의 학생 주도 자조형 CiM(Specialty Speed Dating·Backstage

Pass Elective·운영위원회 학생 대표), Harvard의 단계별 종단 Career Planning(AAMC CiM 자가진단 필수·Society Advisors 공식 미팅·Alternative Medical Careers Series), University of Colorado의 학년별 단계형 진로 행동화(1학년 Awareness·2학년 Decision), UCLA의 6개 가상 College 구조화·레지던시 1:1 코칭, Duke Health/MGH의 평가에 개입하지 않는 타 전공 교수 코치 배치, Johns Hopkins All Children's의 직접 임상 관찰 기반 Resident Coaching 등이 검토되었다. 이들 사례의 공통 함의는 평가권이 배제된 심리적 안전성(psychological safety), 학년별 점진적 마일스톤 설계, 그리고 고학년 집중 개입은 효과가 제한적이므로 저학년부터의 종단 개입이 필요하다는 점이다.

라. 통합 6년제 적용 M1-M6 진로코칭 로드맵

연구팀은 Hur 3단계, AAMC 4단계, STEPS 5과정을 종단 정렬하여 통합 6년제 M1-M6 진로코칭 로드맵을 도출하였다. 학생 발달단계·코칭 과정·코칭 활동·운영 지원·평가 지표를 같은 행에 정렬할 때, 진로 코칭은 비교과 상담을 넘어 정규 교육과정의 한 축으로 작동한다.

학년	Hur 단계	AAMC 단계	핵심 코칭 활동	STEPS 연계	평가 지표
M1	Crystallization 자기이해	Understand Yourself	흥미·가치·역량 자가 진단, 의사 직업 다양성 노출, 조기 임상 노출	Screening 자기진단·기초 자료 수집	자기이해 척도, 진로흥미검사, 직업 노출 빈도
M2	Crystallization 자기이해 심화	Understand Yourself	의료환경 거시 이해, Track 후보 선정, 비임상 경로 탐색	Thinking 구조 분석·진로 가치 명료화	진로 가치 명료성, Track 후보 다양성
M3	Specification 진로계획	Explore Options	Track/EP 계획 수립, 전공별 정보 수집, 멘토링	Expressing 목표·계획 수립	EP 계획서, 전공 후보 압축률, 멘토링 횟수
M4	Specification 진로계획 실행	Explore Options → Choose 전환	EP 실행, 임상 사전 학습, 포트폴리오 누적, 비임상 시도	Performing 실행·경험 축적	EP 실행 완성도, 포트폴리오 항목 수
M5	Implementation 진로결정	Choose Your Specialty	실습 성찰, 진로 통합 해석, 전공 선택 확신 형성	Strengthening 성찰·피드백 순환	전공 선택 확신, 진로결정 자기효능감
M6	Implementation 수련 진입 준비	Prepare for Residency	지원서·면접·매칭 전략, 경력 전환 설계, 평생 학습 준비	Strengthening 지속 가능한 자기조절	매칭 성공률, 진로결정 스트레스 감소

<표 25> 통합 6년제 적용 M1-M6 진로코칭 로드맵(Hur 3단계 + AAMC 4단계 + STEPS 5과정)

이를 종합한 의과대학 진로코칭 통합 모형(재구성안)은 ① 학생 발달단계(M1-M2·M3-M4·M5-M6), ② STEPS 기반 코칭 과정, ③ 핵심 코칭 활동(자기진단·진로멘토링·Track/EP 계획·포트폴리오), ④ 운영 지원체계(전담교수·Track 책임교수·EP 지도교수·e-Portfolio-LMS), ⑤ 기대 결과(자기효능감·자기주도성·전문직 정체성·사회적 책무성)의 5층 구조로 구성된다.

마. 한국형 의학교육 진로코칭 체계 구축 방안

2025-2026년 통합 6년제 개편기에 Enrichment(심화·특화) 트랙 구축이 최우선 과제로 강조되고 있는 정책적 기회를 활용하여, 과학적으로 검증된 일대일 맞춤형 코칭 모델을 공교육 인프라에 안착시키기 위한 네 가지 구축 방안을 다음과 같이 제시하였다. 진로 코칭 혁신은 단순한 매칭 도구가 아니라 예비 의사의 전인적 정체성 복원 과정이다.

구축 방안	전략	기전·내용
① KAMC 표준 e-Portfolio 기반 환류 시스템	학업 도달도·Career Anchor 검사·임상실습 정성 평가를 누적하는 전산화된 e-포트폴리오를 교육과정에 내장	학생은 매 학기 "계획-점검-피드백" 자가 규제 루프를 가동하고, 교수자는 추측이 아닌 객관적 데이터 기반으로 밀착 코칭 수행
② 국내 우수 코칭 프로그램의 전국적 확산	유효현·박귀화 등의 의전원 진로설계과정(자기 이해 향상 3.60점·전공 정보 만족 3.56점), Hur 등의 코칭 도구를 대학 여건에 맞추어 보급	검증된 국산 매뉴얼은 각 전공의 장래성 대처법을 포함하여 한국형 진로 의사결정 성공 지표를 양산
③ 대학-지도교수-학생상담실 다기관 연계	정보 허브(대학)·정서 신뢰(지도교수)·정신건강 전문성(학생상담실)의 유기적 결합	지도교수가 스트레스·부적응적 회피 대처를 스크리닝 → 고위험 시 학생상담실 즉시 연계 → 마인드풀니스·전문 심리진료 병행으로 번아웃·학업중단 방지
④ 교수자 전문 코칭 역량 개발(FD)	임상의·의과학자인 교수들에게 평가가 배제된 수평적·촉진적 코칭 대화법의 정식 학습 기회 제공	긍정 심리학적 질문법·경청의 단계·Action Plan 도출법·인증 코칭 풀 확보·교원평가 내 "코칭 기여도" 항목 가시화

<표 26> 한국형 의학교육 진로코칭 체계 구축 방안

8. 전국 의과대학 적용 사례: 권역별 성과공유세미나

No.	대학	핵심 주제	주요 내용
1	가톨릭의대	학생 맞춤형 진로지원 체계 구축	진로토크쇼 4회(해외 의생명과학 연구자·동문 임상·의사과학자·정부/국회 보건의료정책 진로 탐색, 2025.11~2026.1) 운영, 학생 코호트-두루누리 시스템 연계 고도화, e-포트폴리오 기반 임상실습 이력·졸업역량 통합관리
2	경희의대	입학부터 졸업까지 학생 중심 전주기 혁신	KAMC 위촉입학사정관 워크숍 참여, 의학과 4학년 자기설계 선택실습(55개 기관: 국내 52·해외 3), 멘토-멘티 결연식 150명, 진로미결정 척도(SIS) 활용 진로 탐구, 6개 특성화 Track 설계 참여 및 경희의대 최적화 6년제 교육과정 개발 착수
3	고려의대	자율설계학기·학생 맞춤형 진로 트랙	도전형 학기: 탐색·멘토 매칭 → 선수과목 확인/이수 → 계획서 제출·심의(자율학기 6개월 전) → 중간 점검·최종 발표회의 4단계 진로 코칭 프로세스, P/F 절대평가·포트폴리오 심사·학생 종합평가로 전공 선택·석박사 진입·해외연수 선발에 반영
4	연세의대	입학전형 전략 연구·면접위원 역량 강화	자체 면접역량 강화 워크숍(38명, 2026.4.21)·KAMC 공동 워크숍 참여, 표준화 면접 평가 기준표(영역별 행동지표·점수 기준) 정교화, 신규·기존 면접위원 구분 맞춤형 교육 체계
5	이화의대	AI 기반 연구역량 강화 프로그램	이화 그린리본 프로젝트(104명 AI 교육 이수) → 정규 교과목 「의공학과 AI」 개발 → 인턴십·연구참여(20명+) → 연구 성과 발표회의 "비교과 → 정규 교과목 → 연구 참여" 연계 로드맵, 학년 맞춤형 AI 로드맵 1종
6	중앙의대	AI 융합 교육과정·임상실습 관리 시스템	의료 인공지능 아이디어 경진대회(2025.11.24, 29명·6팀, 지역·보건 연계 주제), 다기관·다임상과 분산 실습을 통합 관리하는 임상실습 관리 시스템 C.A.R.E(로테이션·학습활동·평가·피드백·전자 포트폴리오·대시보드) 도입(2026.9 예정)
7	한양의대	MyPortfolio 자기주도 임상실습 포트폴리오	IC-PBL 기반 실습 + 학생 맞춤형 임상실습 기록 시스템(핵심임상/필수수기·기록지 4단계 UX, AI 기록지 요약·AI 피드백 생성, 담당교수 피드백·5단계 루브릭), 실습 전 가상 공공의료 환자 사례 설계 → 관찰 → 성찰의 폐쇄 루프(Class to Society)

No.	대학	핵심 주제	주요 내용
9	전북의대	지역 의료기관 연계 맞춤형 임상실습	지역사회 기반·지역 정주형·지역사회 대응·사회적 책무성의 4대 목적 기반 임상실습 재설계, 지역 공공의료기관·지역 의료기관 연계 실습, 실습 전·후 인식 변화 정량 평가(만족도·공공보건의료기관 이해도·필요성 인식·진로 연계성)
10	조선의대	통합 6년제 학제·학생 맞춤형 진로 트랙	통합 6년제 교육과정 혁신 TFT·소위원회(인문사회의학·통합교육과정·임상실습·비교과, 회의 13건 이상), 비교과 교육과정 위원회를 통한 핵심 역량 "GREAT" 정의·지표 설정, 트랙 제도 KAMC 컨설팅·외부 자문(2026.8 이후) 예정
11	전남의대	특성화 자율실습·지역 맞춤형 교육환경	강진의료원 등 전남 지역 의료기관 협약 기반 지역 밀착형 특성화 자율실습, 사례분석-대안도출 실습으로 문제해결 역량 강화, 학생 성과공유 워크숍, 지역·공공의료 진로 옵션 관심 확대
12	부산의대	지역사회의학실습·차세대 정보화시스템	보건소 6곳·종합사회복지관 6곳에서 9개 조 편성 지역사회의학실습(가구방문·설문·주민 인터뷰·보건교육: 치매예방·응급질환·골다공증 등), AI 기반 차세대 정보화시스템(포트폴리오·코호트 종단 수집·맞춤형 트랙·진로·역량 추적)
13	고신의대	2026학년도 지역사회 의학 실습과정 신설	기획(2026.1) → 실습병원 모집 → 위원회 심의 → 실습 준비 → OT → 실습 진행 (6.1~6.26, 4주)의 6단계로 6개월 만에 신설, 협력의료기관 33개(부경 5개 대학 공동 실습처 21개, 공공의료기관 6개)
14	울산의대	지역사회기반 의학교육과정 개발	6년 배치 재설계(1년 울산+5년 서울 → 3년 울산+3년 울산/서울), 지역인재 선발 60%·지역의료과정 신설, 울산시·5개 보건소 MOU(2026.2.24), 지역기반의학교육 협의체·의과 학대학원 신설·UNIST 공동 교육과정
15	동아의대	부경 5개 대학 공동 공유교육과정(임상윤리)	4분면 접근법 기반 임상윤리 공유교육과정(동영상 11시수+대면·사례토의 4시수, 15차시) 개발·부산의대·고신의대 적용(만족도 4.69/5.0), 5개 대학 각 1개 교육과정 공동 개발(의사소통·의사학·건강형평성·의료와 국가)
16	인제의대	임상실습 진입 전 임상수행평가 공동 시행	부경 임상수행평가 컨소시엄: 사전회의(2025.10) → 1차 워크숍(15문항) → 2차 워크숍(재검토) → 5개 대학 공동 시행(최종 6문항: 기본술기 2·신체진찰 4), 5대 평가 영역(기본 임상술기·환자안전·임상 추론·의사소통·위임 가능 수준), Delphi-NGT 합의

No.	대학	핵심 주제	주요 내용
17	경상국립의대	부산·경남 5개 대학 지역공공병원 임상실습	5개 공공의료기관(부산의료원·부산보훈병원·창원산재병원·마산의료원·거창 적십자병원)에서 213명 2주 실습, 만족도 4.39/5.0(151명 응답), 사회적 책무성 평가 5개 영역 평균 4.39, 공공보건의료지원 직종 간 IPE 구조
18	제주의대	제주특화 5대 교육영역·K-MedU 공유 교육과정	농어업 직업안전보건·여행의학·야생의학/응급의료·열대감염병/원헬스·노인의학의 제주특화 5대 교육영역, K-MedU 「스토리텔링으로 배우는 환경응급 및 야생의학」(1학점·5 모듈 15차시), 진로코칭 교수단 8트랙 15명, 지역 의료기관 MOU 3건
19	강원의대	지역 임상실습 교육과정·교육공동체 회복 프로그램	지역보건의료 학생인턴실습(의료원 MOU·기숙사·교과목 승계·교통비·숙소·학생관리·커리큘럼의 7단계 운영 체계, 2주 파견), 학생통합지원실 6대 프로그램(심리상담·학습코칭, 군 제대 복학생, 인권침해 정서지원, Med Bridge 학습멘토링, 교직원 회복; 118명, 상담 206회기)
21	한림의대	MedLearn-X AI 기반 의학교육 혁신 플랫폼	AI 문제은행(기출 기반 대량 생성·3개 AI 다중검증·전문가 검수·IRT 분석), 큐레이션(강의 자료 정제·임상 사례 요약·퀴즈 초안), 역량기반 E-Portfolio, 온톨로지·지식그래프(개념 중복·누락 탐지, 선·후수 위계, 결손 추적)의 4대 축
22	단국의대	지역사회 수요맞춤 정주의료인 양성	공유교육과정 2건(외상학 START 16차시·의료와 리더십 15차시), KAMC 문항뱅크 500문항, 졸업 포트폴리오 시범, 충남지역 교류협약 55건, 충남 지역특화 임상실습(천안·홍성·서산·공주의료원 등 5개 기관, 3학년 28명, 2주), 2026.7 전학년 학사정상화 완료
23	순천향의대	학생 중심 의학교육 혁신 11대 과제	6년제 교육과정 개발 21건(목표 6), 의사과학자 교육개발 5건, 문항뱅크 547문항, 지역 의료·공공 MOU 13건, 5학년 선택실습 5개 트랙(지역의료·응급/외상/독성·CPX/다학제/LIC·의사과학자, 만족도 4.45~4.91/5.0), 의사와사회 전문직업성 교과 개발
24	건국의대	학생맞춤형 통합 6년제·지역사회시스템의학	6년 통합 나선형 심화 커리큘럼 5대 연계 요소(EP·학사-석사 통합학위, LC 기반 진로코칭·LC Day, e-포트폴리오, 의사과학자 비교과, 선택형 심화교육), HSS+IPE+LIC+시민성 통합 지역사회시스템의학, K-MedU 3과목 90시수, AI 문항뱅크 1,651문항

No.	대학	핵심 주제	주요 내용
25	충북의대	의사과학자 양성 프로그램·지역의료 거버넌스	의사과학자 입문교육 4개 분야 9개 교과목 개발(2026-2·2027-1 운영 예정), Wet-lab 실습·학생 연구지원·지역연계 인턴십, 충북 지역 7개 기관 업무협의(오송임상시험센터·충주의료원·건국의대 등) 및 거버넌스 선포
26	충남의대	사람 중심 성장단계형 6년 통합교육모델	Learn-Care-Challenge-Serve 교육철학 4축, 3캠퍼스 성장 여정(유성 Discovery & Identity → 세종 Science & Convergence → 문화동/보운 Clinical Responsibility), CNUMED 진로박람회(153명), 산부인과 IPE 시뮬레이션, CNU MED DREAM CAMP(지역 고교생 30명)
27	을지의대	미래형 HUMAN 인재 양성·출연연 연계 교육	HUMAN 역량 프레임워크(Humanistic·Universal·Multidisciplinary·Altruistic·Networking), 출연연 연계 전문가 참여 교육 15회(114~120명, 만족도 4.26~4.64), 인재상 정립 세미나(2026.6.23), 기초과학연구원 연계 인턴십·E-science 교내 연구인턴십
28	건양의대	지역을 품고 미래를 여는 CHARM된 의사 양성	3無 교육(무경계 캠퍼스·교육·진로), 참키움 RISE 지역사회 임상실습(6학년 51명, 18개 기관, 만족도 4.77), 진로탐색 페스티벌 2회(271명, 10개 전공 부스), 학생설계 선택교과(융합형 DYR), 지역 의사 선발전형 거버넌스 세미나(5개교)
29	가천의대	G-IMPACT·GRIT 트랙·G-MERCI 다직종 IPE	GRIT 4개 진로 트랙(Global Medical Talent·Researcher·Innovator·Transformer) 및 G-IMPACT 교육과정개발 TF, 5개 단과대 협의체 IPE(시뮬레이션·덕적도 섬마을·IPE-QI 실습), MEDI-INCHEON 닥터헬기 체험, K-MedU 통합감염학, KAMC LIC 시범운영 선도 대학
30	성균관의대	학생성장형·AI 기반 8대 성과영역	학생맞춤형 교육체계(진로탐색·Career Anchors·요구조사), AI 기반 의학교육(AI-PBL-MEQ 채점), 미래형 평가체계(문제은행·졸업 포트폴리오), 지역의료기관 MOU 13건(경기), 「지역사회 진료현장 실습」 전공필수 신설(M1 46명, 7개 지역 의료기관), 교수역량 워크숍 17회
31	아주의대	지역사회와 미래의료환경을 연결하는 융합형 의사양성	지역사회 기반 실습모듈 6건, 9개 지역기관 실습, 4개 권역센터(외상·소아응급·응급·모자 의료) 필수의료 실습모듈, AI 문항뱅크 1,800문항, 전국 11개 의대 26명 IPE 집중워크숍, AI 미래의학 3과목 도입

No.	대학	핵심 주제	주요 내용
32	인하의대	서해오지섬 백령병원·지역사회기반 13개 프로그램	신입생 「인하와참의사」 백령워크숍, 본4 백령병원·인천의료원·웅진병원 특성화 실습, 학생주도 무의촌 도서 이동진료봉사, 3개 학년 13개 지역사회기반 프로그램, 대만 츠지의대 Silent Mentor 연수, 특성화 2강좌(30시차) 개발
33	차의과학대	CHAM 추진전략 4대 축 통합 성과	Customized(진로검사 5종 맞춤형 진단: COI·MST·16PF·BFI·SLT)·High-tech(K-MedU 2과목: 피부과학·근골격계학)·Advanced Collaboration(IPE 기반 지역협력)·Mission-based(RECOMP 의사과학자, 경기 북부 지자체 MOU 5건)
34	대구가톨릭의대	CARITAS-EP 통합6년제·다층적 Peer-Mentor 코칭	의사과학자·지역의료 2개 특성화 트랙, Enrichment Period 시범(5명, 100% 달성), 다층적 Peer-Mentor 코칭·진로특강 4회(누적 480명, 만족도 4.82), 2027학년도 통합6년제 정규 도입 준비, CARITAS-AI·LoGiC 임상실습 포트폴리오
35	경북의대	RISE 시민성 중심 교육·Core plus 교육과정	3개 교과목 시민성 편성(신규 「환자-의사-사회 2」, 개편 「사례바탕 의료인문 1」·「의사와 윤리」), 시민성·공공성 월례세미나 8회(168명 응답, 만족도 4.83), 지역사회 통합돌봄 현장 답사 파일럿, CMP Scale 사전-사후 전 항목 상승
38	영남의대	OACIS 통합6년제·AI 진로코칭·JYMS 연구	OACIS 5대 교육철학(Outcome-Adaptive-Community-Based-Integration-Spiral) 기반 학년별 Track 편성·Enrichment Period(4~8주)·LIC 시범운영, AI 기반 커리어패스 진로코칭 프로토타입(AI 진단·추천·매칭, 교수 37명·학생 109명 요구조사), 생성형 AI 가상환자 10건, JYMS 학생연구

<표 27> 권역별 성과공유세미나 기반 38개 대학 적용 사례 요약

9. 미래 의료인 양성 방향 및 핵심 가치

본 과제를 통해 도출된 통합 6년제 학생맞춤형 교육과정(Enrichment Period 포함)의 지향점과 핵심 가치는 다음과 같다.

방향	내용
통합 교육	예과-본과 경계 없는 체계적 학습 연계
진로 맞춤형	트랙별 선택 교육과정
실무 역량	임상·연구·공공의료 실습 강화
미래 대응	AI·데이터·글로벌 역량 개발

Enrichment Period 교육과정 핵심 가치:

의과대학생 개인의 적성과 진로에 맞는 맞춤형 교육 제공

예과-본과 통합으로 6년간 체계적 진로 발달 지원 및 연속성 강화

연구, 필수의료, 공공의료, 글로벌 리더십 등 다양한 트랙별 심화 교육 실현

의사소통, 팀워크, 리더십, 데이터 활용 등 미래 의료환경 핵심 역량 강화

04 주요 성과 및 산출물

사업계획서 상 추진과제-산출 목표 대비 본 과제의 주요 성과는 다음과 같다.

구분	성과 내용
교육과정 개발 표준 절차	교육과정 개발 5단계 프로세스(교육 목표-도달 역량-역량별 교육과정-교육과정 편성-실행 방안) 정립 및 KAMC 워크숍 운영 모델 확립
교육목표·역량 체계	학생맞춤형 교육과정 VISION-목적-4대 목표 및 5대 도달역량 체계 도출(워크숍 기반 합의)
트랙별 교육과정(안)	의학연구·탐구 기반 교육과정, 진로·경력설계 기반 교육과정 등 역량별 교육과정(안) 및 6개 EP 트랙(의사과학자, 지역사회의료, 미래의료·디지털헬스, 의료경영·정책, 국제보건·글로벌헬스, 교수요원 양성) 구성(안) 도출
6년 나선형 편성 모델	EP 기간·운영방법 및 나선형(Spiral) 교육과정 구조 설계안 도출 → 교육과정 편성(안) 1안~4안(Track 2개 → 4개, EP 9주 → 18주 → 18주+7주 → 28주+7주) 및 편성표·해설 종합 보고서 확정, 진로코칭(Career Path Coaching) 전략 연계 설계
대학 적용 사례	P대학 통합 6년제 트랙형 교육과정 전면 개편안(트랙별 편성표, 지속적 진로탐색 프로그램 포함) 분석·공유
운영 가이드북·리플렛 배포	「학생 맞춤형 교육과정 개발과 운영 가이드북(Track-EP-STEPS 진로코칭 운영안)」 및 STEPS 진로코칭 활용 리플렛 제작·배포 완료 — 편성(안) 1~4안 편성표, 6개 Track별 6과목 체계, 4주·9주·18주·28주형 EP I 및 EP II 운영안, STEPS 코칭 프로토콜, 운영 여건·평가 체계, 표준 서식 9종 수록
진로코칭 전략 근거 구축	의대생 진로 탐색 실태, 코칭 효과 근거(RCT), 국내외 진로코칭 모형·가이드라인(Hur 3단계, SCCP, AAMC CiM, Canadian Guidelines, UCSF Timeline, Coaching Competency Framework) 고찰 및 통합 6년제 M1-M6 진로코칭 로드맵·한국형 진로코칭 체계 구축 방안 도출
이론적 기반·국제 사례 정리	Core plus 교육과정 정의, 통합 6년제 맞춤형 교육과정 필수 구성요소 8가지, 해외 6개 대학 6년제 벤치마킹, 교육학 이론 9종 적용 체계 정리
전국 대학 사례 수집	권역별 성과공유세미나 발표자료 기반 38개 대학의 학생맞춤형 교육과정·진로코칭·지역사회기반 교육 적용 사례 정리(2차년도 컨설팅·확산의 실증 기반)
38개교 적용 계획 도출	대학별 학생맞춤형 교육과정 및 진로코칭 프로그램 도입을 위한 38개교 적용 계획 도출 지원 완료 (사업계획서 목표 32개교 초과 달성)

구분	성과 내용
운영 실적	워크숍 5회, 세미나 3회, 연구회의 6회, 실무진 회의 25회 운영(2025.7~2026.5, 전체 완료)

<표 28> 주요 성과 및 산출물 요약

최종 성과물로 38개교의 대학별 학생맞춤형 교육과정 및 진로코칭 프로그램 도입 적용 계획이 도출되었으며, 개발·운영 가이드 및 STEPS 진로코칭 활용 자료(가이드북·리플렛)가 제작·배포되었다. 각 대학에 적용되는 진로코칭 핵심 절차는 S(자기진단: 자신의 특성 파악) → T(구조화: 목표 구체화) → E(목표설계: 세부 실행 계획 수립) → P(실행: 계획의 실제 적용) → S(성찰: 과정 평가 및 환류)의 STEPS 5단계로 표준화하였다.

그림과 교육과정 모형

기간별 Enrichment Period(EP) 운영 모형 4주형·9주형·18주형·1년형을 목적과 기간에 맞게 선택하고, 단일 트랙 몰입 또는 트랙 조합으로 운영하는 설계입니다.

Enrichment Period(EP) 운영 모형 선택도

기간과 목적에 따라 단기 탐색형부터 1년형 Extended EP까지 유연하게 설계



그림 5-1. 기간별 EP 운영 모형 요약

그림 크게 보기 ↗

STEPS 모형에 따른 학생맞춤형 교육과정 설계 흐름자기이해와 진단에서 시작하여 학습환경 구성, 목표·교육과정 설계, 자기주도적 실행, 성찰과 확장으로 이어집니다.



그림 크게 보기 ↗

통합 6년제 트랙·EP 교육과정 배치 예시트랙과 집중 학습기간을 6년의 교육과정 안에 배치한 운영안 중 한 가지입니다. 대학별 학사 구조에 맞춰 조정하는 설계 예시입니다.

1안: Track(2개) + Enrichment Period(9주)

월		3월					4월					5월					6월					7월					8월					9월					10월					11월					12월					1월					2월																
주		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52																				
P H A S E 1	1학년	일반교양/외국어/예체능																	Track ①-1 (2학점*1과목) 2주	여름방학(8주)							일반교양/외국어/예체능															Track ②-1 (2학점*1과목) 2주	겨울방학(8주)																														
		지역사회기반 교과목																																																																							
		신입생 세미나																																																																							
	2학년	통합교육							통섭교과					통합교육					Track ①-2 (3학점*1과목) 3주	여름방학(6주)							통합교육					통섭교과					통합교육					진료 수행 시험	Track ②-2 (3학점*1과목) 3주	겨울방학(6주)																													
																																																			지역사회기반 교과목																	의료현장의 이해					
월		3월					4월					5월					6월					7월					8월					9월					10월					11월					12월					1월					2월																
주		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52																				
P H A S E 2	3학년	통합교육							통섭교과					통합교육					Track ①-3 (3학점*1과목) 3주	여름방학(6주)							통합교육							통섭교과					지역사회기반 교과목					통합교육					진료 수행 시험	Track ②-3 (3학점*1과목) 3주	겨울방학(6주)																						
																																																										지역사회기반 교과목															
									의료현장의 이해																									선택과목							의료현장의 이해																						선택과목										
	4학년	통합교육							통섭교과					통합교육					진료 수행 시험	선택과목	여름방학(6주)							통합교육					통섭교과								Enrichment Period *이수한 Track(①②) 중 하나를 바탕으로 진료와 적성에 맞는 활동을 수행하는 기간										겨울방학(6주)							임상 실습 준비 교육															
																																						의료현장의 이해																					의료현장의 이해														
월		3월					4월					5월					6월					7월					8월					9월					10월					11월					12월					1월					2월																
주		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52																				
P H A S E 3	5학년	기본임상실습										통섭교과	기본임상실습										여름방학(4주)					기본임상실습										통섭교과	기본임상실습										종합 시험	겨울방학(4주)																							
	6학년	진료 수행 시험 1학점	선택임상실습																	종합 시험	여름방학(6주)							학생인턴										임상 종합 평가																																			
		Track①-6(금요일 오후)										Track②-6(금요일 오후)																																																													